

中图分类号: R473.5

密 级: 公开

学校代码: 10599

学 号: 20221054486

右江民族医学院

硕 士 学 位 论 文



专业学位

幽门螺杆菌感染患者体质分析及阳虚质中医护
理方案构建

学位申请人: 覃海平

导师姓名: 时宗泽

专业名称: 护理

研究方向: 内科护理

所在院系: 护理学院

申请学位类别: 护理硕士

完 成 日 期: 2025 年 05 月 25 日

广西·百色

目 录

英汉缩略词对照表	11
第一章 前言.....	12
1 研究背景.....	12
1.1 幽门螺杆菌感染率高,与胃癌密切相关	12
1.2 幽门螺杆菌感染危害及相关并发症.....	12
1.3 中医体质与幽门螺杆菌之间的关系.....	12
1.4 幽门螺杆菌感染护理的不足之处.....	13
2 文献回顾.....	13
2.1 中医对幽门螺杆菌感染的认识.....	13
2.2 幽门螺杆菌感染的中医体质研究现状	14
2.3 幽门螺杆菌感染的中医护理研究现状	15
2.4 阳虚质概述.....	16
2.5 幽门螺杆菌感染中医体质护理的思路与方法	17
2.6 文献小结.....	17
3 相关概念界定.....	17
3.1 幽门螺杆菌.....	18
3.2 中医九种体质类型.....	18
4 理论依据.....	19
4.1 中医体质可调论.....	19
4.2 脏腑经络学说.....	20
5 研究目的及意义.....	22
5.1 研究目的.....	22
5.2 研究意义.....	22
6 技术路线.....	22
第二章 幽门螺杆菌感染患者中医体质分析的病例对照研究	24
1 研究目的.....	24
2 对象与方法.....	24
2.1 研究对象.....	24
2.2 研究方法.....	24
3 结果.....	27
3.1 问卷回收结果.....	27
3.2 两组研究对象的基本特征.....	28
3.3 两组研究对象中医体质调查结果.....	29
3.4 幽门螺杆菌感染与体质关系的单因素分析	30

3.5 幽门螺杆菌感染与体质的多因素 logistic 回归.....	31
4 讨论.....	31
4.1 幽门螺杆菌感染患者中医体质分布不同,以阳虚质为主	31
4.2 平和质为幽门螺杆菌感染的保护因素	32
4.3 湿热质为幽门螺杆菌感染的危险因素	32
4.4 阳虚质为幽门螺杆菌感染的危险因素,其显著性高于湿热质	33
4.5 小结.....	34
第三章 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建	36
1 文献研究.....	36
1.1 研究目的.....	36
1.2 研究方法.....	36
1.3 结果.....	39
2 构建 Hp 感染阳虚质患者中医体质护理方案初稿	47
3 德尔菲法.....	50
3.1 遴选函询专家.....	50
3.2 制作专家咨询问卷.....	50
3.3 函询过程.....	51
3.4 统计学分析.....	51
3.5 指标筛选标准.....	51
3.6 质量控制.....	51
3.7 德尔菲专家函询结果.....	51
4 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案的修订与完善	60
5 讨论.....	63
5.1 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的必要性	63
5.2 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的科学性	63
5.3 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的合理性	63
5.4 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的适用性	64
不足与展望.....	65
结论.....	66
参考文献.....	67
附录.....	77
综述 中医特色护理在幽门螺杆菌感染防治中的创新应用与进展	97
参考文献.....	105

幽门螺杆菌感染患者体质分析及阳虚质中医护理方案构建

摘 要

目的：（1）分析中医体质与幽门螺杆菌感染之间的关系，探讨幽门螺杆菌感染的危险体质因素。（2）基于德尔菲法，构建幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案，为幽门螺杆菌感染患者体质护理工作的开展提供理论依据。

方法：（1）本研究采用成组病例对照研究方法，选取 2023 年 10 月至 2024 年 5 月期间，百色市两所三甲医院首次诊断为幽门螺杆菌感染的门诊患者 450 例为病例组，同期选取该医院体检中心体检的幽门螺杆菌非感染者 150 例作为对照组。采用一般资料调查表、中医体质量表（成人版）进行调查，调查前均已获得调查对象知情同意。（2）数据分析采用 SPSS 27.0 统计软件进行，采用 t 检验、 χ^2 检验分析对病例组和对照组的基本情况，采用单因素和非条件多因素二元 logistic 回归分析幽门螺杆菌感染的危险体质因素。（3）构建幽门螺杆菌感染危险体质因素的中医体质护理方案：基于前期调查结果，通过系统性文献回顾，构建并形成幽门螺杆菌感染危险体质因素的中医体质护理方案初稿。实施两轮德尔菲专家函询，根据专家意见对方案进行修改和完善，最终形成幽门螺杆菌感染危险体质因素的中医体质护理方案终稿。

结果：（1）本次研究纳入的病例组为幽门螺杆菌感染患者 450 例，对照组共纳入幽门螺杆菌非感染者 150 例，两组样本人群在年龄、性别、民族、籍贯、婚姻状况等基线资料的比较中，差异均无统计学意义（ $P>0.05$ ）。（2）非条件多因素二元 logistic 回归分析显示：平和质（ $OR=0.519$ ，95% CI : 0.301~0.897， $P=0.019$ ）是幽门螺杆菌感染的保护因素；阳虚质（ $OR=3.21$ ，95% CI : 1.906~5.406， $P<0.001$ ），湿热质（ $OR=2.359$ ，95% CI : 1.331~4.18， $P=0.003$ ）是幽门螺杆菌感染的危险因素。阳虚质、湿热质占比分别为 34%、20.4%，阳虚质为本研究幽门螺杆菌感染的首要危险体质因素。（3）文献回顾时共检索出 1140 篇文献，最终纳入文献 10 篇，教材 4 本，归纳总结幽门螺杆菌感染

患者阳虚质 16 条证据内容，并形成 70 个条目的护理方案初稿。实施两轮德尔菲专家函询，共有 16 位专家参加，两轮专家函询问卷的有效回收率均为 100%，专家权威系数(Cr)均为 0.90，第一轮和第二轮的 *Kendall* 协调系数分别为 0.135 ($P<0.05$) 和 0.182 ($P<0.05$)。最终形成 7 个维度（一级条目）、17 个子领域（二级条目）、34 项具体干预措施（三级条目）共 58 个条目的标准化护理方案。

结论：（1）本研究提示幽门螺杆菌感染与中医体质存在相关性，阳虚质是幽门螺杆菌感染的首要危险体质因素，平和质为保护因素；（2）基于德尔菲法构建的幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案内容科学、咨询结果可靠，方案构建具有合理性。

关键词：幽门螺杆菌感染；中医体质；阳虚质；体质护理；方案构建

Constitution analysis of *Helicobacter pylori* infection patients and construction of traditional Chinese medicine nursing scheme of Yang deficiency

ABSTRACT

Objective: (1) Analyze the relationship between traditional Chinese medicine constitution and *Helicobacter pylori* infection, and explore the risk factors of *Helicobacter pylori* infection. (2) Based on the Delphi method, the traditional Chinese medicine nursing plan of Yang deficiency in patients with *Helicobacter pylori* infection was established to provide a theoretical basis for the development of physical nursing work for patients with *Helicobacter pylori* infection.

Methods: (1) A group case-control study was adopted in this study. A total of 450 outpatient patients diagnosed with *H. pylori* infection for the first time in two Class A hospitals in xxx City from October 2023 to May 2024 were selected as the case group, and 150 non-infected patients who underwent physical examination in the physical examination center of the hospital were selected as the control group during the same period. General data questionnaire and Traditional Chinese Medicine Physique Scale (adult version) were used for investigation, and informed consent of survey subjects was obtained before investigation. (2) SPSS27.0 statistical software was used for data analysis. T-test and chi-square test were used to analyze the basic information of the case group and the control group. Univariate and unconditioned multivariate binary logistic regression were used to analyze the risk factors of *H. pylori* infection. (3) Construction of traditional Chinese medicine constitution nursing plan for the risk constitution factors of *Helicobacter pylori* infection: Based on the previous investigation results and systematic literature review, the first draft of traditional Chinese

medicine constitution nursing plan for the risk constitution factors of Helicobacter pylori infection was constructed and formed. Carry out two rounds of expert letter consultation with Delphi method, revise and improve the first draft according to the expert opinions, and finally form the final draft of traditional Chinese medicine physique nursing plan for the risk physique factors of Helicobacter pylori infection.

Results: (1) The case group included in this study included 450 patients with Helicobacter pylori infection, and the control group included 150 non-infected patients with Helicobacter pylori infection in the physical examination center. There was no statistical significance in the comparison of baseline data such as age, sex, nationality, native place and marital status between the two groups ($P > 0.05$). (2) Unconditioned multivariate logistic regression analysis showed that peace and quality ($OR=0.519$, 95% CI : 0.301-0.897, $P=0.019$) were protective factors for H. pylori infection. Yang deficiency ($OR=3.21$, 95% CI : 1.906~5.406, $P < 0.001$) and damp heat ($OR=2.359$, 95% CI : 1.331~4.18, $P=0.003$) were risk factors for H. pylori infection. Yang deficiency and damp-heat were 34% and 20.4%, respectively. Yang deficiency was the primary risk factor of Helicobacter pylori infection. (3) In the literature review, a total of 1140 literatures were retrieved, 10 literatures and 4 textbooks were finally included, 16 pieces of evidence of Yang deficiency in patients with Helicobacter pylori infection were summarized, and the first draft of nursing plan with 70 items was formed. A total of 16 experts participated in the two rounds of Delphi expert letter consultation. The effective recovery rate of the two rounds of expert letter consultation questionnaires was 100%, the expert authority coefficient (Cr) was 0.90, and the *Kendall* coordination coefficient of the first round and the second round was 0.135 ($P<0.05$) and 0.182 ($P<0.05$), respectively. Finally, a standardized nursing program consisting of 58 items in 7 dimensions (first-level items), 17 sub-areas (second-level items), and 34 specific interventions (third-level items) was formed.

Conclusion: (1) This study suggests that there is a correlation between Helicobacter pylori infection and traditional Chinese medicine constitution. Yang deficiency is the primary risk factor of Helicobacter pylori infection, and peace is the protective factor. (2) Based on the Delphi method, the traditional Chinese medicine nursing plan for Helicobacter pylori infection patients with Yang deficiency is scientific in content and reliable in consulting results, and the plan construction is reasonable.

Key words: Helicobacter pylori infection; Traditional Chinese Medicine (TCM) constitution; Yang deficiency temperament; Physical fitness care; program construction

英汉缩略词对照表

英文缩写	英文全称	中文全称
BMI	Body Mass Index	体质指数
¹³ C-UBT	¹³ C-Urea Breath Tests	碳 13—尿素呼气试验
GC	Gastric Cancer	胃癌
Hp	Helicobacter pylori	幽门螺杆菌
PU	Peptic Ulcer Disease	消化性溃疡
TCM	Traditional Chinese Medicine constitution	中医体质
UBT	Urea Breath Tests	尿素呼气试验
WGO	World Gastroenterology Organization	世界胃肠病学组织
WHO	World Health Organization	世界卫生组织

第一章 前 言

1 研究背景

1.1 幽门螺杆菌感染率高，与胃癌密切相关

幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*, Hp）是一种微需氧的革兰氏阴性菌，定植于人类胃黏膜，是目前已知的唯一能在人胃中存活并致病的病原菌^[1]。世界胃肠病学组织（WGO）统计显示，全球约 44 亿人携带 Hp，Hp 整体感染率达 50.8%，其中发展中国家感染率为 78.7%，显著高于发达国家（34.7%），其感染率存在地区差异^[2]。我国作为 Hp 高感染区域，据 2012 年~2022 年中国 Hp 流行病学的 Meta 分析数据表明，我国的 Hp 综合感染率为 42.11%，从地域上看，西北部的感染率最高，为 45.71%，西南地区为 42.40%，华南地区为 34.43%，东北地区感染率为 26%，Hp 感染率呈显著的地理差异^[3,4]。Hp 感染与多种消化系统疾病密切相关，包括慢性胃炎、胃溃疡和胃癌等^[5-7]。随着国家卫生经济等不断发展，人们对健康越来越重视，Hp 感染的相关治疗及护理也逐渐引起社会公众的关注。

1.2 幽门螺杆菌感染危害及相关并发症

世界卫生组织（WHO）已将 Hp 列为胃癌的 I 类致癌原^[8]，其传播已成为世界公认的一个重大公共卫生问题^[9]。尽管现代医学已形成“铋剂四联疗法”等规范化治疗方案^[10]，但临床实践中仍面临抗生素耐药性增加、Hp 根除率降低等难题^[11]。铋剂的应用也有所争议，长期大剂量使用铋剂会出现呕吐、肝肾功能损伤、皮肤黏膜疾病等毒副作用，严重者甚至可引发铋剂性脑病和神经系统的损害，这使得铋剂四联疗法在一定程度上对临床的使用也有所限制^[12,13]。反复治疗失败使患者经受诸多的药物不良反应，承受巨大的心理压力，加上反复就医导致的误工误时等所致的社会经济负担增加不容忽视^[14]。Hp 产生的尿素酶，能够水解尿素生成氨，刺激胃黏膜，发生炎症反应，进而造成对胃黏膜的损伤，使 Hp 感染患者可出现上腹痛、反酸、烧灼感、消化不良、口臭等临床症状，严重降低患者的生活质量^[15]。

1.3 中医体质与幽门螺杆菌之间的关系

尽管西医在 Hp 感染治疗中取得一定进展,但宿主个体差异性(如遗传、免疫、生活方式)对感染转归的影响逐渐被重视。多项 Hp 感染与中医体质的研究中显示,不同地理环境和气候因素的不同其中医体质分布也存在差异,但研究发现 Hp 感染与阳虚质、湿热质等偏颇体质密切相关^[16-18]。中医体质九分法分为正常体质和偏颇体质两大类,偏颇体质的人,体内阴阳气血已经失衡,具有发生疾病的倾向,这在一定程度上决定了疾病的发展和转归^[19]。中医体质学作为研究人体“偏颇体质”与疾病易感性关联的独特理论体系,为探索 Hp 感染的宿主因素提供了新视角,例如通过辨识体质类型(如阳虚质等),可制定个体化护理方案,弥补传统治疗“千人一方”的不足^[20]。中医体质学说认为,体质是可调整的,体质既有稳定性又有可变性,偏颇体质者很容易发生疾病,通过护理干预,人的体质偏颇失衡状态可以得到改善和调整,从而恢复健康^[21]。

1.4 幽门螺杆菌感染护理的不足之处

现有的 Hp 感染护理方案多基于西医指南,如四联疗法用药指导、饮食禁忌等^[22],忽视中医体质差异对治疗反应的影响。同一护理措施可能因体质不同导致依从性差异,例如阳虚质患者对寒凉饮食更为敏感^[23]。在中医护理方面,部分研究尝试引入艾灸^[24]、药膳^[25]等中医技术,但多为单一技术应用,零散化干预难以发挥中医“整体调理”优势,且循证证据薄弱,缺乏严格的德尔菲专家共识支持,因此本研究基于 Hp 感染偏颇体质构建个性化的护理方案,可为 Hp 感染患者体质护理工作的开展提供理论依据。

2 文献回顾

2.1 中医对幽门螺杆菌感染的认识

中医理论体系中,并无幽门螺杆菌病名, Hp 感染可归属“胃脘痛”“痞满”“湿阻”等范畴,其发病与“外邪侵袭”“脾胃虚弱”“湿热蕴结”等密切相关^[20]。《黄帝内经》提出“正气存内,邪不可干”,说明体内正气不足是 Hp 滋生的重要内因^[26]。目前现代多数医家将其归属于“邪气入侵”,“邪气”经口而入,直中脏腑,引发疾病^[12]。临床辨证中, Hp 感染者常见脾胃虚寒、脾胃湿热、寒热错杂等证型,治疗注重“扶正祛邪”,通过温阳健脾、清热化湿等法调节体质偏颇,为中西医结合防治提供了独特思路^[27]。

2.2 幽门螺杆菌感染的中医体质研究现状

2.2.1 中医体质的概念与内涵

中医学中的体质是指人体生命过程中，在先天禀赋和后天基础上形成的形态结构、生理功能和心理状态的综合的、相对稳定的特征，是人体在生长发育过程中根据自然和社会环境而形成的人体个性特征^[28]。体质的形成与先天因素和后天影响有关，先天因素包括禀赋及胎传，后天因素包括饮食和营养、日常生活和起居、心理和情绪、自然和社会环境因素、疾病和药物等^[29,30]。王琦的体质九分法将中医体质分为九种，分别为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、气郁质、特禀质、血瘀质，其中平和质为正常体质，其余八种均为偏颇体质^[31]。该体质分类法是由王琦院士团队通过大样本流行病学研究建立的，已成功应用于代谢综合征^[32,33]、过敏性鼻炎^[34,35]等疾病的防治。体质九分法成为中华中医药学会颁布的体质分类标准^[31]，该标准是我国第一部指导和规范中医体质研究和应用的文件，至今仍广泛沿用，为体质辨识、中医体质相关疾病的防治、养生保健和健康管理提供依据，使体质分类科学化、规范化^[28]。中医体质学也为现代疾病护理发展开辟了新领域，实施辨体施护为疾病护理的研究提供了新的视角和方法^[36]。

2.2.2 国内 Hp 感染的中医体质研究现状

国内对 Hp 感染相关疾病与中医体质的研究较为丰富，但仅局限于 Hp 感染与中医体质的相关性研究。在中医体质的辨识区分上，中医体质量表是体质辨识的基础工具，通过积分计算来判定体质类型，是应用最广泛的中医体质标准化测量工具^[37]，分为儿童版、成人版及老年人版中医体质量表。判定标准是根据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定》^[31]对体质进行判定，临床上部分辅以红外热成像仪、人体成分分析仪、中医四诊仪等仪器进行辅助判定。陈瑶等^[17]收集北京地区 384 例 Hp 感染相关性胃炎患者资料，统计发现以湿热质居多，特禀质最少；游佳琪^[16]通过分析黑龙江某医院 450 例体检人员发现，Hp 感染与中医体质关系密切，得出 Hp 感染患者的偏颇体质多见于阳虚质、湿热质；刘慧等^[38]探讨了九种中医体质与 Hp 感染阳性率之间的相关性，研究结果显示阳虚质、气虚质和湿热质与 Hp 感染存在显著正相关；王美蓉等^[39]通过分析深圳市

龙岗区 Hp 感染患者中医体质类型分布中得出, Hp 阳性的患者中, 中医体质类型主要表现为痰湿质, 其次为湿热质、阳虚质; 潘慧人对广东 600 例 Hp 感染患者及祁松对安徽医院 506 例研究对象的研究^[18, 40]中, 发现 Hp 感染人群均以湿热质、痰湿质居多。

综上分析, 不同地区 Hp 感染的体质分布结果多存在差异, 可能与地域、饮食习惯不同等因素有关^[18, 41], 但总体分析中发现 Hp 感染与湿热质、阳虚质、痰湿质、气虚质这几种体质类型关系较为密切。研究内容上, 国内的研究仅限于 Hp 感染与中医体质的相关性研究, 缺少针对 Hp 感染危险体质的中医体质护理方案构建, 因此本研究构建针对 Hp 感染危险体质的中医体质护理方案, 可为患者提供个性化体质护理, 促进机体恢复健康, 为 Hp 感染防治提供中医体质护理实践及理论参考。

2.2.3 国外 Hp 感染的中医体质研究现状

国外虽无中医体质学完整理论体系, 但伴随中医学在世界范围内的普及, 很多外籍人员逐渐接受中医体质学的相关理论, 并制定出日语版、韩文版、英文版的中医体质量表, 这推动了中医体质向国际化发展^[42]。国外针对中医体质的相关研究, 限于糖尿病、高血压、痛风、缺血性脑卒中、肺癌、抑郁等疾病与中医体质的相关研究^[43-48], 目前 Hp 感染与中医体质的相关文献较为少见。

2.3 幽门螺杆菌感染的中医护理研究现状

2012 年, 国家中医药管理局首次将中医护理学纳入“十二五”重点专科建设, 并相继制定和推进优势病种中医护理方案, 有力推动了中医护理的有效发展^[49]。Hp 感染患者常伴腹痛、腹胀、食欲不振等胃肠道不适症状, 是慢性胃炎、消化性溃疡等胃肠道疾病发生发展的重要原因^[50]。但相关研究发现社会公众对 Hp 感染认识不足^[51-53]、患者对 Hp 感染治疗依从性不足^[54-56]等问题。中医在 Hp 感染的护理中除起居调护、情志调摄、饮食调理、运动调理外, 尚有其独特的中医外治技术, 如穴位按摩、穴位贴敷、艾灸等^[57, 58]。但现代医学对 Hp 感染的护理方案普遍存在内容同质化, 未体现个体化差异, 中医护理研究中, 虽然也有对体质的研究, 但仅在疾病与体质类型的相关研究, 忽视了针对个体体质的护理。在中医体质辨识的基础上对 Hp 危险体质患者进行相关的中医护理方案构建, 例如通过中医特色疗法来调理脾胃, 以改善病人胃肠道不适等症状, 通过加

强饮食、生活起居、运动等护理方法以促进病人对 Hp 感染危险体质的认知及治疗依从性，对提升患者生活质量、预防 Hp 感染相关并发症及促进患者康复具有重要意义。

2.4 阳虚质概述

2.4.1 阳虚质概念与内涵

阳虚质是先天禀赋不足或后天失养而致的阳气不足，以畏寒怕冷、手足不温、怕吃凉物为主证的一种偏颇体质状态^[59]。王琦院士带领团队完善和发展了中医体质理论，阐述了阳虚的机理和具体表现：由于先天禀赋不足或后天各种环境因素的影响，导致人体阳气受损，阳气不能在人体各个层面充分发挥作用，形成阳虚体质，一般形体趋于白胖，肌肉松软，心理特征比较沉静内向；临床表现以畏寒肢冷、手足不温、精神不振、舌淡胖、边有齿痕、脉沉迟等为主；不耐受寒邪，耐夏不耐冬；易感湿邪；发病多为寒证，或易从寒化^[59]。由此可见，从症状上讲，改善阳虚体质实质上就是补充人体阳气，使身体机能恢复正常^[60]。

2.4.2 阳虚质与疾病的关系

研究表明，在现代社会背景下，由于缺乏锻炼、高温贪凉、生活作息不规律等原因，阳虚体质人群的比例逐年增加，占总人口的 14.8%，是比例偏大的偏颇体质人群^[61, 62]。阳虚体质的人后期容易出现寒湿、血瘀、阴阳两虚等症状，并容易伴有代谢紊乱、免疫力低下、消化系统疾病甚至精神疾病等多种疾病^[63]。罗辉等^[64]全面总结了阳虚质与疾病的关系，发现骨质疏松症、肠易激综合征、膝关节骨性关节炎、大肠息肉和高血压等是阳虚体质人群占比最高的疾病类型。由此可见，阳虚对健康影响复杂，因此也成为近年来的研究热点。

2.4.3 阳虚质与幽门螺杆菌感染的关系

由于当前生活节奏较快，人们常在生活工作之中存在不良的饮食和作息习惯等，使人体脏腑功能失调，容易出现阳虚症状^[38]。阳虚质人群与消化系统疾病密切相关，而 Hp 感染是慢性胃炎、消化性溃疡等消化系统相关疾病的重要病因^[10]，因此两者之间存在密切关系，游佳琪^[16]、刘慧等^[38]研究证实了这一观点。阳虚体质的人阴阳失衡，会导致血气、肝气郁结，改善阳虚质，对 Hp 感染的临床护理和体质改善具有重要意义。

2.5 幽门螺杆菌感染中医体质护理的思路与方法

中医体质学说认为，体质是可以调整的，偏颇的体质是疾病滋生的温床，如果缺乏正常的体质，那么疾病“种子”便可滋生，所以治病应当先对体质进行护理^[65]。体质可调是实施“治未病”的重要手段^[66]，基于体质可调来指导 Hp 感染的临床防治及日常体质护理，具有至关重要的作用。从文献研究看，偏颇体质是多种慢性病的危险因素，而 Hp 感染可导致胃部相关性慢性疾病的发生^[67]。Hp 感染规范化治疗管理中将患者相关健康教育纳入 Hp 感染管理核心措施^[10]，表明了 Hp 感染相关护理的重要性。近年来，在护理实践中关于中医体质的健康护理在疾病防护领域的应用价值逐渐凸显^[19, 68-70]。因此，为了预防 Hp 感染疾病的发生和发展，研究可以从危险体质人群入手，通过对体质的辨识，到对体质的护理，从体质的状态和不同体质的特点分类，掌握其健康或疾病的一般要素和个体差异，制定 Hp 感染预防和护理的原则。一般体质护理方法分为以下几个方面：辨体质施膳、辨体质施术（穴位按摩、穴位贴敷、耳穴压豆等）、辨体质调情志、生活起居调护、运动调护等^[67]。根据体质辨识，了解 Hp 感染的中医体质分布规律并识别其危险体质类型，构建相关危险体质的中医护理方案，为患者的健康教育和偏颇体质护理提供参考依据^[68]。

2.6 文献小结

Hp 感染刺激胃黏膜，使 Hp 感染患者可出现上腹痛、反酸、烧灼感等胃肠道不适症状，严重降低患者的生活质量。中医体质学从体质出发，探讨疾病与体质的相关性，并从偏颇体质入手进行调理，将偏颇体质转化成平和体质，可促进机体健康。目前针对 Hp 感染的中医体质研究仍处于疾病感染与中医体质类型的相关性研究，不同地区 Hp 感染的体质分布存在差异，但与湿热质、阳虚质、痰湿质、气虚质几种体质关系较为密切。在 Hp 感染的护理上，目前研究的护理方案内容普遍同质化、缺乏个体化护理。Hp 感染与阳虚质存在一定的相关性，不同地区研究阳虚质分布不同，本研究将进一步验证其相关性，并构建相关的体质护理方案。目前中医护理对 Hp 感染危险体质的护理研究较少，缺乏成熟的体质护理方案。

3 相关概念界定

3.1 幽门螺杆菌

3.1.1 理论定义

幽门螺杆菌 (*Helicobacter pylori*, Hp) 是一种寄生于人体胃黏膜、有鞭毛的革兰染色阴性微需氧型细菌, 它广泛定植于胃黏液层与胃上皮之间, 一般不侵入细胞内, 是目前已知的、唯一一种可以在人胃中生存的致病菌^[1]。

3.1.2 操作性定义

UBT (尿素呼气试验 (urea breath test, UBT)) 是临床最常用的非侵入性诊断方法, 具有操作简便、准确性较高和不受 Hp 在胃内灶性分布影响等优点^[71]。根据本研究临床实际, 以碳 13 尿素呼气试验 (13C-UBT) 作为诊断标准, 吹气定量测定值 (delta over baseline, DOB) $\geq 4.0\%$ 判定为 Hp 感染阳性, DOB $< 4.0\%$ 判定为 Hp 感染阴性^[72]。

3.2 中医九种体质类型

3.2.1 理论定义

中医九种基本体质是王琦在古代体质分类方法的基础上形成的, 他带领课题组结合临床实践, 运用文献研究、流行病学等方法, 对体质进行分类, 包括平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质, 其中平和质为正常体质, 其余八种均为偏颇体质, 现对九种体质类型特征进行表述^[59]。①平和质: 是中医体质中的正常体质类型, 是阴阳气血调和的健康体质, 是一种以体态适中、面色红润、精力充沛等为主要特征的一种体质, 先天禀赋良好, 后天调养得当, 一般患病少, 对自然和社会环境适应能力较强。②气虚质: 是中医体质中的一种偏颇体质类型, 指元气不足, 易疲劳、气短、自汗等以气虚为主要特征的体质类型, 不耐风、寒、湿、暑, 易患感冒、脏腑脱垂等疾病, 病后恢复慢。③阳虚质: 是中医体质中的一种偏颇体质类型, 指阳气不足, 以畏寒怕冷、手足不温、喜热饮食、精神不振等虚寒表现为主要特征的体质类型, 耐夏不耐冬, 易感风、寒、湿邪, 易患痰饮、肿胀、泄泻等病, 感邪易从寒化。④阴虚质: 是中医体质中的一种偏颇体质类型, 指阴液不足, 以口干、手足心热等为主要表现特征的体质类型, 耐冬不耐夏, 易患虚劳、遗精、失眠等病, 感邪易从热化。⑤痰湿质: 是中医的偏颇体质之一, 是指痰湿凝聚的体质, 主要表现为肥胖、腹满、口黏等痰湿表

现,对雨季和潮湿环境适应力差,易患消渴、中风、胸痹等病。⑥湿热质:是中医体质中的一种偏颇体质类型,指湿热内蕴,主要表现为面部油腻、口苦、苔黄腻等湿热表现,不耐受夏末秋初气候、湿重或气温偏高环境,易患黄疸、热淋等病。⑦血瘀质:是中医体质中的一种偏颇体质类型,指血液循环不畅,主要表现为肤色晦暗、舌质紫暗,不耐寒,易疼痛、气血失调等血瘀症状。⑧气郁质:是中医体质中的一种偏颇体质类型,指气机郁滞,以神情抑郁、忧虑脆弱等气郁表现为主要特征的体质类型,对精神刺激适应能力差,不适应阴雨天气,易患脏躁、百合病及郁证等。⑨特禀质:是中医体质中的一种偏颇体质类型,指禀赋不耐,以过敏反应等为主要特征的体质类型,对外界环境适应能力差,对易致敏季节适应能力差,易患哮喘、荨麻疹、花粉症及药物过敏等。

3.2.2 操作性定义

根据中华中医药学会的《中医体质分类与判定》标准^[31]进行体质判定,平和质为正常体质,气虚质、阳虚质、阴虚质、湿热质、痰湿质、血瘀质、气郁质、特禀质 8 种体质均属于偏颇体质。通过计算量表转化分来判定体质类型,①平和质判定:当转化分 ≥ 60 分且其他 8 种体质转化分均 < 30 分,平和质判定为是;当转化分 ≥ 60 分且其他 8 种体质转化分均 < 40 分,平和质判定为基本是;当不满足上述条件者,平和质判定为否。②偏颇体质判定:当转化分 ≥ 40 分,偏颇体质判定为是;当转化分为 30-39 分,偏颇体质判定为倾向是;当转化分 < 30 分,偏颇体质判定为否。

4 理论依据

4.1 中医体质可调论

中医体质学的理论基础,主要来源于中医理论中的哲学思想和藏象理论,即精气、阴阳、五行学说和脏腑经络、精气血津液理论。中医体质可调论作为中医体质学的核心理论之一,源远流长,植根于中医经典理论,历经数千年的临床实践检验与发展^[36]。体质可调理论认为人的体质既有稳定性又有可变性,通过身体干预可以改善和调节人体体质的不平衡状态,从而恢复健康^[36]。个人应当依据自身的身体状况和体质类型,及时采取针对性的措施,以纠正因气血阴阳失衡所导致的身体偏颇状态,从而有效预防或延缓疾病的发生^[67]。该理论对本研究的启示是可通过体质辨识分析 Hp 感染的易感体质,对

该体质进行中医护理调护，调护的大致方向包含精神调摄、饮食调护、起居调适、运动养生、中医特色疗法等，促进体质的偏颇状态向正常的平和质转化。本研究应用体质可调论的理论框架如图 1-1 所示。

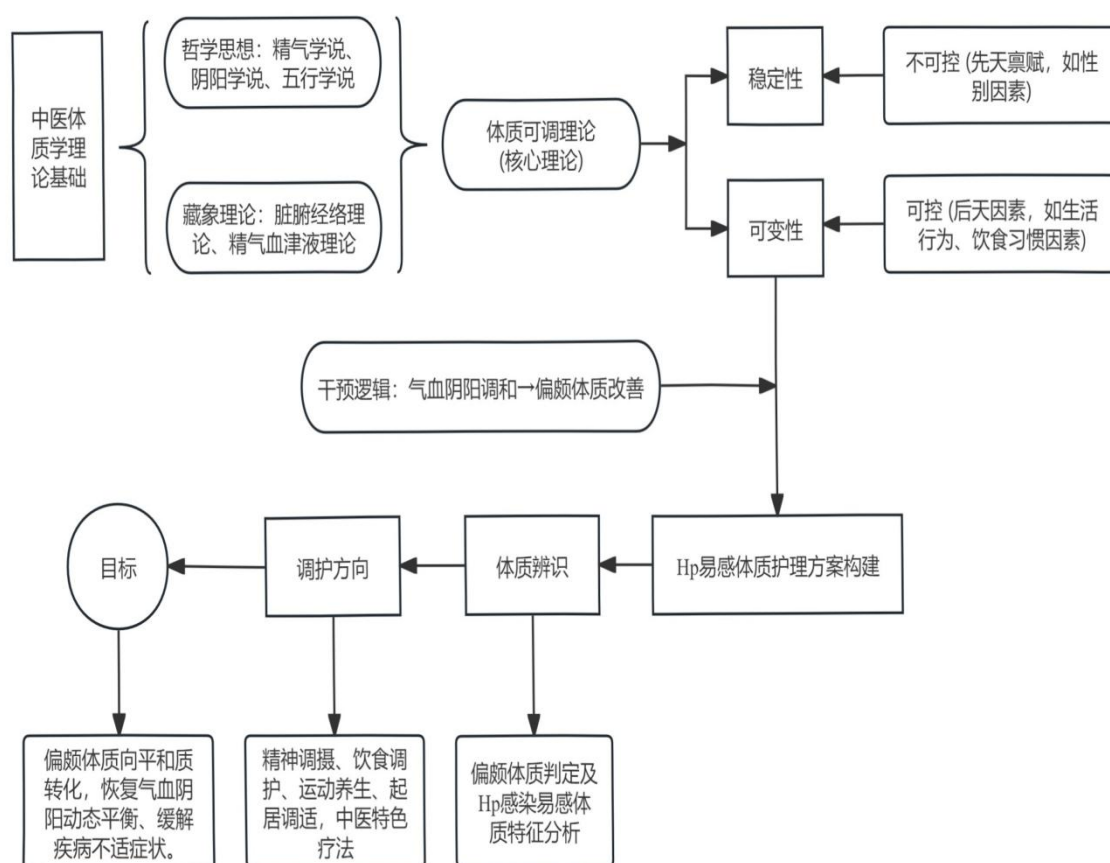


图 1-1 中医体质可调论在本研究中的应用体现

Figure 1-1 The application of the theory of adjustable constitution of traditional Chinese medicine in this study

4.2 脏腑经络学说

脏腑经络学说是中医体质学的生理学基础，脏腑作为人体各器官系统，负责维持机体正常的生命活动，人体所有生理机能均依赖于脏腑的功能协调，而经络作为人体生理结构之一，内属于脏腑，外络于肢节，是人体气血运行的道路^[73]。体质不仅取决于脏腑

功能活动的强弱，而且依赖于各脏腑功能活动的协调，经络是实现这种联系和沟通的结构基础。脏腑经络各分阴阳，故气血阴阳的多少亦有定数，不同的人脏腑精气阴阳盛衰不同，经络中的气血也不同，表现在体外也有所区别^[74]。经络中气血充盛，则身体强壮；气血不足，则身体虚弱多病^[75]。脏腑经络学说对本研究的指导意义为 Hp 感染与中医的脾胃有关，涉及有胃经、脾经以及相关的穴位，比如足三里、中脘等，在中医护理方案上可包含穴位按摩、艾灸等方法，调节相关经络气血，改善体质，提高身体抗病能力。本研究应用脏腑经络学说的理论框架如图 1-2。

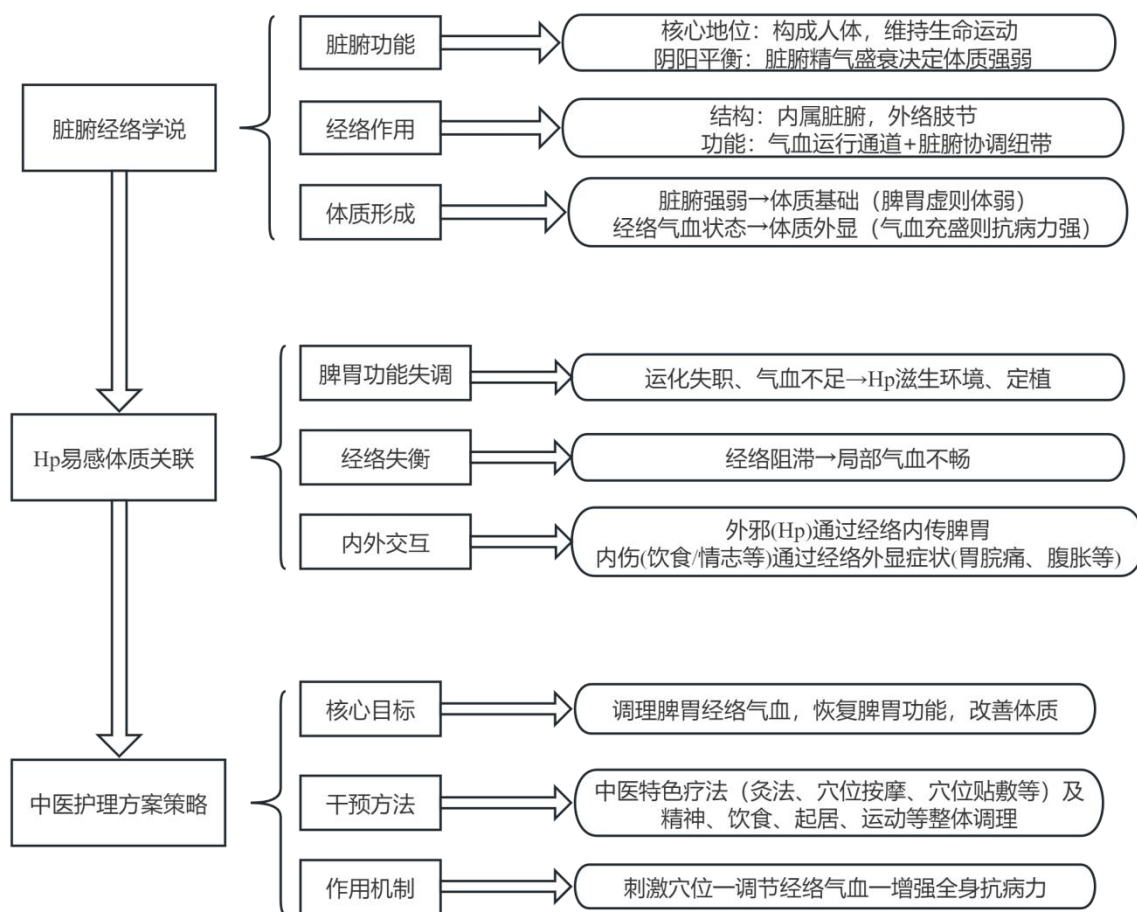


图 1-2 脏腑经络学说在本研究中的应用体现

Figure 1-2 Application of Zang-fu meridians theory in this study

5 研究目的及意义

5.1 研究目的

分析中医体质与 Hp 感染之间的关系，探讨 Hp 感染的危险体质因素；基于德尔菲法，构建 Hp 感染患者阳虚质中医护理方案。

5.2 研究意义

本研究从理论层面可拓展中医护理的理论框架，为 Hp 感染阳虚质人群提供理论指导，推动了中西医结合治疗和护理在消化系统疾病中的应用。从现实层面可为 Hp 感染的护理提供新思路，提高临床护理的针对性，改善 Hp 感染阳虚质人群的整体健康状况，提升其生活质量。

6 技术路线

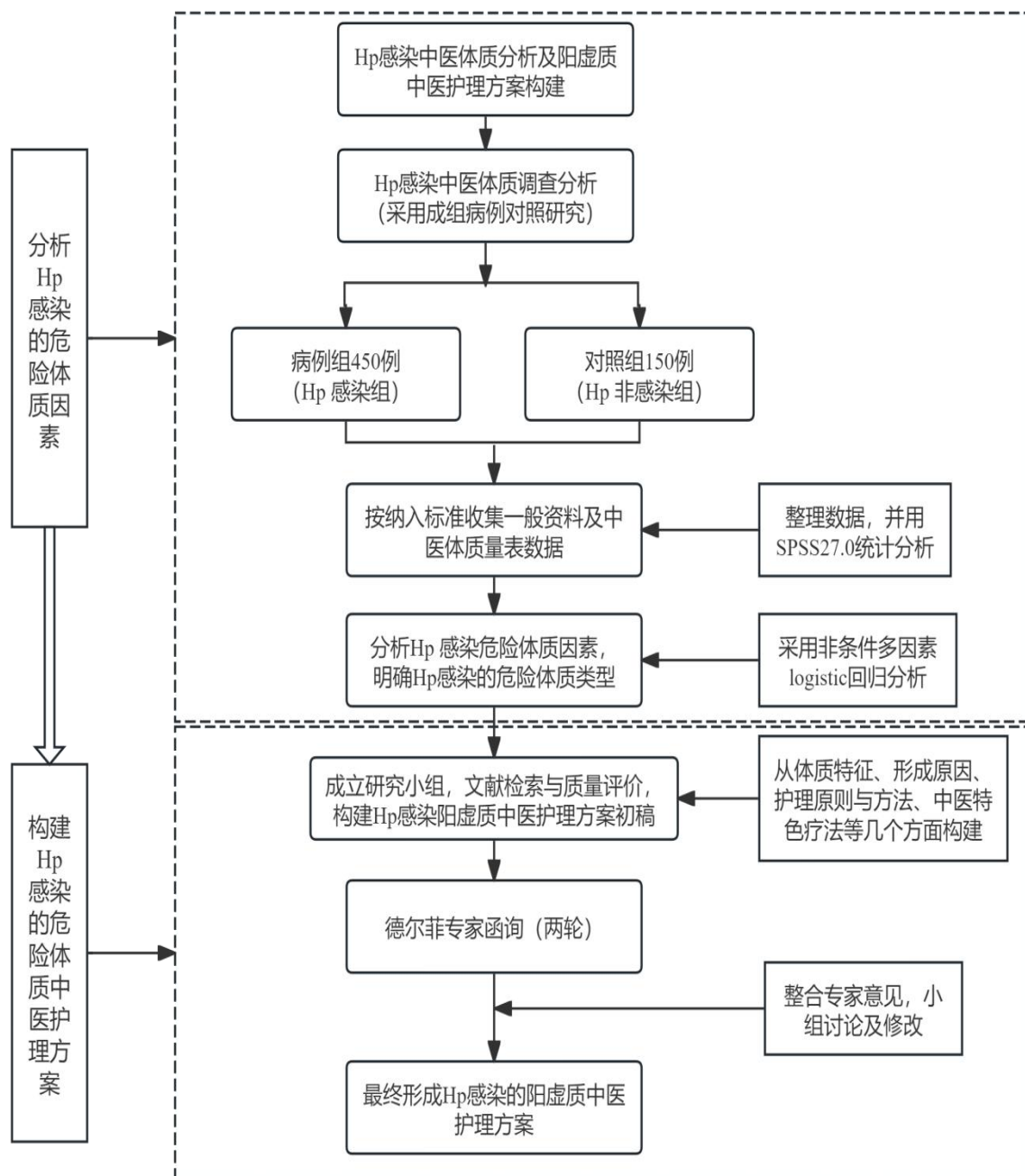


图 1-3 技术路线图
Figure 1-3 Technology roadmap

第二章 幽门螺杆菌感染患者中医体质分析的病例对照研究

1 研究目的

了解幽门螺杆菌感染与中医体质的分布规律，分析幽门螺杆菌感染的危险体质因素，为方案构建提供现实依据。

2 对象与方法

2.1 研究对象

2.1.1 研究对象来源

选择 2023 年 10 月至 2024 年 5 月在百色市某两所三甲医院符合纳入标准的 Hp 感染患者 450 例作为病例组；同时，从该两所医院的体检中心体检的 Hp 非感染人群 150 例作为对照组。

2.1.2 病例组纳入排除标准

(1) 纳入标准：①参照中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组制定的《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》^[7]标准符合 13C 尿素呼气试验阳性的 Hp 首次感染者；②年龄 ≥ 18 岁且 < 65 岁^[59]；③同意参加本次研究并签署知情同意书；④意识清醒，具备理解分析和填写问卷的能力。

(2) 排除标准：①在过去一个月或两周内用过抗生素、铋剂、质子泵抑制剂或 H₂ 受体阻滞剂；②患有严重基础疾病者，如心、脑、肝、肾和内分泌疾病。

2.1.3 对照组纳入排除标准

(1) 纳入标准：①首次进行 13C 尿素呼气试验，且符合 13C 尿素呼气试验阴性的 Hp 未感染的一般人群或患者；②年龄 ≥ 18 岁且 < 65 岁^[59]；③同意参加本次研究并签署知情同意书；④意识清醒，具备理解分析和填写问卷的能力。

(2) 排除标准：①患有严重基础疾病者，如心、脑、肝、肾和内分泌疾病。

2.2 研究方法

2.2.1 研究类型

采用成组病例对照研究的方法，在征得患者同意后进行调查。

2.2.2 样本量计算

采用成组病例对照研究的样本估计。参照孙振球、徐勇勇^[76]主编的 2014 年第 4 版《医学统计学》所需样本量计算公式如下：

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2}\sqrt{2pq} + Z_{\beta}\sqrt{p_0q_0 + p_1q_1})^2}{(p_1 - p_0)^2}$$

$q_0=1-p_0$, $q_1=1-p_1$, $p=(p_0+p_1)/2$, $q=1-p$, $P_1=(OR \times P_0)/(1-P_0+OR \times P_0)$, 根据文献^[16]Hp 感染对照组阳虚质暴露率 P_0 为 24%, $OR=2$, 设 $\alpha=0.05$ (双侧), $\beta=0.10$, $Z_{\alpha/2}=1.96$, $Z_{\beta}=1.28$, 代入公式计算得到 $n=120$, 即病例组与对照组每组需收集样本 120 例, 考虑 10% 的样本无效率, 设每组样本量为 x , $x(x-10\%)=120$, 最终求得 $x=134$ 例, 即病例组和对照组样本量应至少分别纳入 134 例。本研究纳入病例组 450 例, 对照组 150 例, 均符合样本量要求。

2.2.3 研究工具

2.2.3.1 调查工具

(1) 一般资料调查表

在查阅文献和咨询专家的基础上, 研究人员自行设计了一般信息调查问卷, 内容包括性别、年龄、民族、婚姻状况、职业、教育程度、居住条件、居住状况和家庭人均月收入等一般人口学信息 (见附录 1)。

(2) 中医体质量表 (成人版)

成人版《中医体质量表》是由王琦^[59] 开发的标准化测量工具, 用于评估 18 岁以上且 65 岁以下成人的中医体质类型, 是目前使用最广泛的中医体质标准化测量工具^[37]。该量表是一个由 9 个亚量表 (平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质) 结构构成, 总共 60 个条目, 以自填为主的标准化量表。该体质量表 9 个亚量表的 Cronbach's 系数为 0.72~0.80, 重测信度为 0.77~0.90, 具有良好的信度^[77]。效度检验中以简明健康状况调查问卷 (SF-36) 作为效标, 进行效标效度的评

价，结果显示平和质得分与 SF-36 总分为 0.58 的正相关，各偏颇体质类型得分与 SF-36 总分是-0.54~-0.38 的负相关^[59]。区分效度中将调查对象按身体质量指数（Body Mass Index, BMI）分为肥胖者组和非肥胖者组，进行中医体质量表各亚量表得分的比较分析，结果显示肥胖者组痰湿质（ $P<0.001$ ）、气虚质（ $P<0.001$ ）得分明显高于非肥胖者组，与中医学“肥人多痰”“人之肥者气必虚”的理论相符，说明中医体质量表具有良好的区分效度^[59]。

2.2.3.2 中医体质分类的判定

（1）判定方法

调查对象自行填写成人版《中医体质量表》所有问题（见附录 2）。量表共 60 个条目，各个条目按 5 级评分，研究者计算原始分及转化分，依标准^[31]判定体质类型（体质分类判定见附录 3），每个亚量表的分数分别计算，然后将 9 个亚量表的各个条目相加，得出 9 种体质的原始分数，再将其转换为标准化分数，每个亚量表的转化分从 0 到 100 分不等，数值越高，体质倾向越明显^[59]。①原始分=各条目分值相加；②转化分=（原始分-条目数）/（条目数×4）×100。

（2）判定标准

平和质为正常体质，其他 8 种为偏颇体质，平和质和偏颇体质判定标准见表 2-1。

表 2-1 成人版九种体质判定标准表
Table 2-1 Adult version of nine physical criteria

体质类型	条件	结果
平和质	转化分≥60 分	是
	其他 8 种体质转化分均<30 分	
	转化分≥60 分	基本是
	其他 8 种体质转化分均<40 分	
偏颇体质	不满足上诉条件者	否
	转化分≥40 分	是
	转化分 30~39 分	倾向是
	转化分<30 分	否

2.2.4 资料收集方法

本研究资料收集的场所在消化内镜室门诊及体检中心进行,经取得科室管理员同意下,在征得研究对象的同意后,研究人员向符合纳入标准的研究对象面对面发放调查问卷。为确保调查的可行性和信息的真实性,研究人员向研究对象详细解释调查的目的与意义。研究人员当天发放问卷并现场回收所有问卷,并逐项检查核对,以确保资料真实及完整性。

2.2.5 数据处理与统计分析

数据采用 SPSS 27.0 软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,不符合正态分布的计量资料采用中位数及四分位数间距表示;计数资料采用例数、构成比表示,两组间比较采用 χ^2 检验,并采用非条件多因素二元 Logistic 回归分析。所有假设检验均为双尾,以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2.2.6 质量控制

①人员培训:调查开始前统一对研究人员进行培训,明确填写方式,并告知注意事项及解答疑问。②问卷发放:由研究人员现场发放问卷并当场回收,向研究对象详细说明填写问卷的目的、要求及方法,在不受他人影响的前提下填写问卷,填写完毕后,研究人员现场回收调查问卷。③资料核查、整理:按照纳入标准进一步确认,以确保内容的真实准确性,回收问卷后回顾浏览问卷的条目,如发现漏填条目,应让研究对象填写缺失条目后才可纳入研究,按照中医体质判定标准,对患者中医体质进行分类。④数据录入:由两名研究人员同时录入数据,录入完成后交由另外一名研究人员进行信息核查,以确保数据的真实性和准确性。

2.2.7 伦理原则

本课题已获得右江民族医学院伦理委员会审批同意(伦理审批号为:2023122615)。研究过程中,严格遵循保密原则,不外泄关于研究对象身份的任何资料。所有研究对象均以自愿为原则,对本研究知情同意,并可随时退出。

3 结果

3.1 问卷回收结果

共发放问卷 605 份, 病例组发放 453 份, 回收 453 份, 对照组发放 152 份, 回收 152 份, 共回收 605 份, 回收率 100%; 剔除填写不完整的无效问卷 5 份, 其中病例组 3 份, 对照组 2 份, 最终纳入有效问卷 600 份, 有效率 99.17%。

3.2 两组研究对象的基本特征

本研究最终共纳入 600 名研究对象, 病例组 450 人, 对照组 150 人。病例组男性 226 例 (50.2%), 女性 224 例 (49.8%), 平均年龄为 (45.44±10.54) 岁; 对照组男性 71 例 (47.3%), 女性 79 例 (52.7%), 平均年龄为 (42.73±11.14) 岁。两组社会人口学特征分析显示, 两组人群在一般情况比较中无统计学意义, 具有可比性 ($P>0.05$), 详见表 2-2。

表 2-2 病例组与对照组一般人口学特征比较[$\bar{x}\pm s/n$ (%)]

Table 2-2 Comparison of general demographic characteristics of the case and control groups[$\bar{x}\pm s/n$ (%)]

变量	分组	病例组 ($n=450$)	对照组 ($n=150$)	χ^2/t	P
性别	男	226 (50.2%)	71 (47.3%)	0.376	0.540
	女	224 (49.8%)	79 (52.7%)		
年龄 (岁)		45.44±10.54	42.73±11.14	-2.681	0.080
民族	汉族	122 (27.1%)	49 (32.7%)	1.953	0.377
	壮族	293 (65.1%)	92 (61.3%)		
	其他民族	35 (7.8%)	9 (6.0%)		
籍贯	广西	372 (82.7%)	136 (90.7%)	6.438	0.085
	云南	54 (12.0%)	10 (6.7%)		
	贵州及其他	24 (5.3%)	4 (2.7%)		
婚姻状况	未婚	47 (10.4%)	22 (14.7%)	1.971	0.160
	已婚	403 (89.6%)	128 (85.3%)		
职业	工人/农民	267 (59.3%)	77 (51.3%)	4.619	0.327
	学生	14 (3.1%)	3 (2.0%)		
	商业/行政/服务 业人员	64 (14.2%)	28 (18.7%)		
	专业技术人员	44 (9.8%)	20 (13.3%)		
文化程度	离退休/其他	61 (13.6%)	22 (14.7%)	2.096	0.718
	小学及以下	169 (37.6%)	54 (36.0%)		
	初中	112 (24.9%)	40 (26.7%)		

(续表)

变量	分组	病例组 (n=450)	对照组 (n=150)	χ^2/t	<i>P</i>
文化程度	高中/中专	47 (10.4%)	21 (14.0%)	2.096	0.718
	大专及以上	122 (27.1%)	35 (23.3%)		
居住条件	城市	222 (49.3%)	81 (54.0%)	0.980	0.322
	农村	228 (50.7%)	69 (46.0%)		
居住状况	独住	38 (8.4%)	20 (13.3%)	3.709	0.079
	合住	412 (91.6%)	130 (86.7%)		
家庭人均月收入 (元)	<1000	22 (4.9%)	17 (11.3%)	21.054	0.070
	1000-2000	159 (35.3%)	59 (39.3%)		
	2000-3000	186 (41.3%)	44 (29.3%)		
	>3000	83 (18.4%)	30 (20.0%)		

3.3 两组研究对象中医体质调查结果

两组人群中医体质辨识中, 根据九种中医体质判定标准结果为是、倾向是、否, 本研究将倾向是结果归为是; 患者中医体质辨识包含单一体质与兼夹体质, 按最大值法对兼夹体质进行处理判定最终的中医体质。病例组最常见的体质为阳虚质 (34%), 对照组最常见的体质为平和质 (21.3%), 两组体质统计分析可详见表 2-3。

表 2-3 病例组与对照组中医体质类型分布表

Table 2-3 Distribution of TCM physique types in case group and control group

体质类型	病例组 (构成比%)	对照组 (构成比%)
平和质	36 (8.0%)	32 (21.3%)
气虚质	82 (18.2%)	28 (18.7%)
阳虚质	153 (34.0%)	22 (14.7%)
阴虚质	21 (4.7%)	13 (8.7%)
痰湿质	29 (6.4%)	15 (10.0%)
湿热质	92 (20.4%)	18 (12.0%)
血瘀质	11 (2.4%)	7 (4.7%)
气郁质	14 (3.1%)	8 (5.3%)
特禀质	12 (2.7%)	7 (4.7%)
合计	450 (100%)	150 (100%)

3.4 幽门螺杆菌感染与体质关系的单因素分析

以九种中医体质作为自变量，以是否感染 Hp 作为因变量进行单因素分析，单因素分析结果中，Hp 感染在阳虚质、平和质、湿热质方面比较，差异有统计学意义($P<0.05$)，Hp 感染在气虚质、阴虚质、痰湿质、血瘀质、气郁质、特禀质方面比较，差异无统计学意义 ($P>0.05$)，详见表 2-4。

表 2-4 幽门螺杆菌感染体质的单因素分析表
Table 2-4 Single factor analysis of Helicobacter pylori infection constitution

体质类型	分组	Hp 感染组 (n=450)	Hp 非感染组 (n=150)	χ^2	P
平和质	是	36 (8.0%)	32 (21.3%)	19.903	<0.01*
	否	414 (92.0%)	118 (78.7%)		
气虚质	是	82 (18.2%)	28 (18.7%)	0.015	0.903
	否	368 (81.8%)	122 (81.3%)		
阳虚质	是	153 (34%)	22 (14.7%)	20.354	<0.01*
	否	297 (66%)	128 (85.3%)		
阴虚质	是	21 (4.7%)	13 (8.7%)	3.367	0.067
	否	429 (95.3%)	137 (91.3%)		
痰湿质	是	29 (6.4%)	15 (10%)	2.093	0.148
	否	421 (93.6%)	135 (90%)		
湿热质	是	92 (20.4%)	18 (12%)	5.358	0.021*
	否	358 (79.6%)	132 (88%)		
血瘀质	是	11 (2.4%)	7 (4.7%)	1.909	0.167
	否	439 (97.6%)	143 (95.3%)		
气郁质	是	14 (3.1%)	8 (5.3%)	1.573	0.210
	否	436 (96.9%)	142 (94.7%)		
特禀质	是	12 (2.7%)	7 (4.7%)	1.468	0.226
	否	438 (97.3%)	143(95.3%)		

注：*为 $P<0.05$

3.5 幽门螺杆菌感染与体质的多因素 logistic 回归

以 Hp 感染作为因变量，Hp 非感染作为参考，将体质单因素分析结果中具有统计学意义的体质因素进行非条件多因素二元 logistic 回归分析。自变量包括平和质、阳虚质、湿热质，将自变量进行赋值（见表 2-5），参考类别以第 1 个作对比，展示了具有统计学意义的体质因素对 Hp 感染的影响情况，具体表现为平和质（ $OR=0.519$ ，95% CI : 0.301~0.897， $P=0.019$ ）发生 Hp 感染是非平和质发生 Hp 感染的 0.52 倍，相对于偏颇体质而言，平和质感染 Hp 减少，为 Hp 感染的保护因素；阳虚质（ $OR=3.21$ ，95% CI : 1.906~5.406， $P<0.001$ ）发生 Hp 感染是非阳虚质发生 Hp 感染的 3.21 倍，湿热质（ $OR=2.359$ ，95% CI : 1.331~4.18， $P=0.003$ ）发生 Hp 感染是非湿热质发生 Hp 感染的 2.36 倍，阳虚质及湿热质均使 Hp 感染增加，均是 Hp 感染的危险体质因素，详见表 2-6。

表 2-5 变量赋值情况
Table 2-5 Variable assignments

变量	赋值
平和质	否=0，是=1
阳虚质	否=0，是=1
湿热质	否=0，是=1

表 2-6 Hp 感染体质非条件多因素二元 logistic 回归分析表
Table 2-6 unconditioned multivariate binary logistic regression analysis of Hp infection constitution

变量	<i>B</i>	<i>SE</i>	Wald	<i>P</i>	<i>OR</i> (95% <i>CI</i>)
平和质	-0.655	0.279	5.524	0.019	0.519 (0.301~0.897)
阳虚质	1.166	0.266	19.229	<0.001	3.21 (1.906~5.406)
湿热质	0.858	0.292	8.649	0.003	2.359 (1.331~4.18)

注：类别参考类型为 Hp 非感染者，表中仅展示具有统计学意义的相关因素。

4 讨论

4.1 幽门螺杆菌感染患者中医体质分布不同，以阳虚质为主

本研究结果显示，Hp 感染患者中医体质分布存在差异，以阳虚质最多（占 34%）。分析本次研究中阳虚质在 Hp 感染中的分布高的原因，阳虚质主要症状有畏寒怕冷，手

足不温，喜热饮食，精神不振，舌淡胖嫩，脉沉迟等^[78]。黄帝内经曰：“阳在外，阴之使也，阴在内，阳之守也”，阳气相当于人体的免疫力，阳不足，则百病生^[79]。熬夜、喜食冷饮、吹空调等，这些特点可能导致其对 Hp 的易感性增加，例如阳虚体质的人脾胃功能较弱，容易出现消化不良、胃痛等症状，这可能为 Hp 的生长繁殖提供了适宜的环境，脾胃虚弱是其发病的根源，因此该体质比例更高^[30]，这与连丽娟^[80]、郑翊轩等^[81]研究一致。本研究中阳虚质为 Hp 感染的主要偏颇体质类型，体现了不同地理环境、经济卫生状况、饮食习惯人们感染 Hp 的中医体质各不相同。在护理上，启发研究人员可针对阳虚质相关症状表现，例如畏寒怕冷、手足不温及 Hp 感染脾胃虚弱等制定个体化的体质护理方案。

4.2 平和质为幽门螺杆菌感染的保护因素

研究结果显示，平和质（ $OR=0.519$ ，95% CI : 0.301~0.897， $P=0.019$ ）是 Hp 感染的保护因素，表明平和质人群感染 Hp 的风险较低。这一结果与中医理论中平和质为“健康体质”的观点一致^[82]。阴阳平衡、脏腑功能协调是平和质的一般特征，一般表现为面色润泽、头发浓密有光泽、目光有神、唇色红润、不容易疲劳、精力充沛、耐热耐寒、睡眠和食欲好、大小便正常、性格随和开朗、不容易患病、对自然和社会环境的适应能力较强^[82]，因此使其对 Hp 的易感性降低。现代研究表明，Hp 感染与宿主的免疫状态密切相关，而平和质人群的免疫系统功能更为稳定，从而减少了感染的风险^[83]。此外，平和质人群通常具有健康的生活方式和饮食习惯，如规律饮食、适量运动等，这些因素也可能间接降低 Hp 感染的风险^[84]。近期研究还发现，平和质健康人群的胃肠道微生态环境更为平衡，这可能通过抑制 Hp 的定植和繁殖，进一步降低感染风险^[85]。因此，平和质作为 Hp 感染的保护因素，不仅体现了中医体质学说的科学性，也为 Hp 感染的防护提供了新的思路，这也启发护理人员需通过调节体质的偏颇以促进患者机体向健康的平和质转化。

4.3 湿热质为幽门螺杆菌感染的危险因素

研究结果显示，湿热质（ $OR=2.359$ ，95% CI : 1.331~4.18， $P=0.003$ ）是 Hp 感染的危险因素，表明湿热质人群感染 Hp 的风险较高。湿热质是偏颇体质之一，表现为面色

油腻，易长痤疮，口苦口干，大便黏滞或干结、小便短黄、舌质偏红、苔黄腻等症状，易怒急躁，对夏末秋初湿热气候、湿气较重或高温环境较难适应^[82]。现代研究表明，脾胃湿热证是 Hp 感染常见的证型之一^[27]，湿热质人群的胃肠道环境通常为湿热蕴结，这种环境可能为 Hp 的定植和繁殖提供了有利条件。中医学认为 Hp 作为一种病邪极易滞留于人体胃脘部，损伤脾胃经脉，阻碍全身气机运行，久而化热，加重脾胃湿热而形成恶性循环，给 Hp 的滋生定植提供了舒适的环境^[86]。此外，湿热质人群的饮食习惯通常偏好肥甘、辛辣、油腻食物，这些食物可能刺激胃黏膜，增加 Hp 感染的风险^[87]。因此，湿热质作为 Hp 感染的危险因素，也提示护理人员在临床中应关注湿热质人群的 Hp 感染情况，并通过调整饮食结构和生活习惯等来降低感染风险。

4.4 阳虚质为幽门螺杆菌感染的危险因素，其显著性高于湿热质

4.4.1 阳虚质的一般特征及发病倾向

阳虚质是中医体质学中的一种偏颇体质类型，是以阳气不足、畏寒怕冷、手足不温等虚寒表现为主的一种体质类型，常见表现为平时畏寒怕冷，手足冰凉不温，喜热食，精神不振，舌淡胖嫩，脉沉迟等症状，性格多表现沉静、内向，对环境适应能力为耐夏不耐冬，易感风、寒、湿邪^[82]。阳虚质的成因与先天不足及后天失养有关，先天因素例如与孕育时父母体弱或年长受孕，早产有关，后天因素包括饮食不节、劳逸失度、情志失调、疾病药物、环境因素等^[59, 88]。阳虚质人群易患消化系统疾病^[89]，有研究发现消化性溃疡以阳虚质为多，且易感染 Hp^[90]；王雨等^[91]研究发现阳虚质是慢性萎缩性胃炎患者的主要体质类型之一，也是慢性萎缩性胃炎发病的重要危险因素之一；杨艺^[92]在十二指肠溃疡与中医体质关系的研究中，发现阳虚质是主要的偏颇体质之一，且以女性及老年人群体居多；杨陶陶^[93]研究中功能性消化不良以阳虚质多见。中医理论认为若脾胃阳虚，“中焦如沤”功能失调，不能收纳腐熟之物，则出现恶心、反酸症状；不能运化水谷精微，水液化湿，水湿停滞，则出现腹泻、泄泻、水肿症状；不能升降气机，则出现胃痞、胃胀、胃痛症状^[63]。中西医结合治疗幽门螺杆菌的专家共识中也是表明了脾胃虚寒证是 Hp 感染的证型之一，阳虚质人群因阳气不足，易出现脾胃虚寒的症状^[27]。

4.4.2 阳虚质与幽门螺杆菌感染的关系

本研究发现，阳虚质（ $OR=3.21$ ，95% CI : 1.906~5.406， $P<0.001$ ）是 Hp 感染的危险因素，且显著性高于湿热质（ $OR=2.359$ ，95% CI : 1.331~4.18， $P=0.003$ ），表明本研究中阳虚质人群感染 Hp 的风险显著增加。其发生机制可从胃内环境改变、胃黏膜屏障破坏及菌群失调三个方面进行分析。从中医理论看，阳虚质以脾肾阳虚为核心病机，导致“内寒”环境形成，这为 Hp 定植创造适宜环境^[30]。在黏膜防御层面，赵鹏飞^[94]的研究表明，阳虚质组的 Th1/Th2 细胞在细胞免疫区分泌细胞因子的能力低于平和质组，这表明他们的免疫水平有不同程度的下降。免疫应答是人体维持内外环境平衡的重要机制，如果免疫功能受到干扰，机体的平衡就会被打破，从而导致病变的发生^[95]。胃肠道菌群失调的相关研究进一步揭示，阳虚质能够影响胃肠道菌群生态，而 Hp 感染可通过影响胃内胃酸分泌改变肠道微生物群，两者均与胃肠道菌群失调密切相关^[96, 97]。

4.4.3 幽门螺杆菌感染阳虚质患者的中医体质护理思路

通过分析阳虚质的成因，先天因素为不可控因素，后天因素通过长期影响人体阳气生成，逐步导致体质偏颇，护理上主要从后天因素进行^[98]。脾胃为后天之本，气血生化之源，Hp 感染会影响脾胃的运化功能，导致食物不能有效转化为气血精微，从而影响阳气的生成^[99]。中医上以“温阳益气，扶正祛邪”为原则，通过增强机体阳气、改善脾胃功能进行调理^[96]。Hp 感染阳虚质患者的体质护理目前初步思路可从饮食上调理温中健脾，调和胃气；生活起居上固护阳气，保暖防寒，作息规律，适度运动；从情志上调摄，疏肝温阳；进行中医特色疗法（如艾灸生阳）；健康教育，进行个体化指导，如服药指导，自我监测等多个方面进行，具体仍需结合中医理论与现代循证医学依据，形成个性化、个体化的护理方案。

4.5 小结

本研究通过系统分析 Hp 感染患者的中医体质分布特征及风险关联性，揭示了体质与 Hp 感染存在相关性，明确了阳虚质、湿热质为 Hp 感染的独立危险因素，阳虚质显著性高于湿热质，且阳虚质在 Hp 感染患者的体质分布中居于首位。本研究平和质为 Hp 感染的保护因素，平和质阴阳平衡，脏腑功能协调，为健康体质，阳虚质阳气不足、湿热质湿热蕴结，均为偏颇体质，启示护理人员可通过对偏颇体质进行护理干预，使体质

的偏颇失衡状态向健康的平和质转化，为 Hp 感染防控提供体质护理依据。本研究结果显示阳虚质是 Hp 感染的首要危险体质因素，目前针对 Hp 感染阳虚质患者的护理仍缺乏标准化的中医护理方案，这也启示我们可通过系统化文献检索，构建出针对该体质 Hp 感染患者的中医护理方案，为后续 Hp 感染患者进行体质的个性化护理提供理论依据。

第三章 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建

1 文献研究

1.1 研究目的

基于前期数据调查结果，阳虚质为 Hp 感染的主要危险体质因素（ $P<0.05$ ），且在本研究中阳虚质分布频率居于 Hp 感染首位，目前仍无系统化的基于体质分型的 Hp 感染阳虚质护理方案，因此需进行系统性文献回顾提炼 Hp 感染相关阳虚质的相关护理内容，为后期阳虚质护理方案的应用提供理论依据。

1.2 研究方法

1.2.1 成立研究小组

研究小组成员由 7 人组成，包括主任医师 1 人，主任护师 1 人，副主任护师 1 人，主管护师 2 人，硕士研究生 2 人。成员具体分工详见表 3-1。

表 3-1 研究小组成员分工明细表

Table 3-1 Detailed division of labor of research team members

成员角色	职称	职责分工
质量控制	主任医师	1.对方案内容进行把控，审核及确定方案中体质的护理调理方法，例如中医护理技术的选择、穴位的确定等。 2.参与小组讨论，完善和修订研究方案，终审研究方案终稿。
组长	主任护师	1. 统筹项目整体设计与进度管理。 2. 协调跨学科合作，遴选函询专家（如联系消化科医师、中医专家等）。 3. 把控研究伦理与质量控制。 4. 参与小组讨论，完善和修订研究方案，终审研究方案终稿。
副组长	副主任护师	1. 协助组长制定研究计划。 2. 监督每日/周进度。 3. 主持小组例会讨论方案内容。 4. 参与小组讨论，完善和修订研究方案。
数据管理组	主管护师 A、主管护师 B	1. 数据录入与核查（双人核对），建立数据库。 2. 整理函询专家相关资料。 3. 参与小组讨论，完善和修订研究方案。

(续表)

成员角色	职称	职责分工
科研组	硕士研究生 A (本人)	1. 文献检索与质量评价, 循证工具应用 (如 Cochrane 协作网对 RCT 的质量评价)。 2. 构建研究方案初稿。 3. 编制专家函询问卷并发放、收集函询问卷。 4. 进行小组讨论, 并完善和修订方案终稿。
科研支持组	硕士研究生 B	1. 协助研究者 A 进行文献检索与质量评价。 2. 协助统计并分析专家函询数据。 3. 参与小组讨论, 完善和修订研究方案。

1.2.2 文献检索

(1) 文献检索策略

计算机检索 PubMed、Cochrane Library、Up to Date、中医药在线、中国中医药数据库、中华医学全文数据库、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方数据库、维普数据库等与 Hp 感染阳虚质相关的文献, 检索时限从建库至 2024 年 6 月。检索与调理阳虚质及 Hp 感染患者中医护理有关的所有文献 (具体检索式以中国知网及 PubMed 为例, 详见表 3-2)。为保证研究文献的完整性, 以“中医体质”“中医护理”等为关键词检索学校图书馆相关教材书籍作为体质调理指导。

表 3-2 检索式示例表
Table 3-2 List of search examples

检索工具及方法	具体检索式
(1) 中国知网: 结合使用主题词与自由词检索策略: 以“幽门螺杆菌”或“Hp 感染”或“HP 感染”为主题词, 匹配“阳虚质”或“阳虚体质”或“阳虚证”或“脾肾阳虚”等体质相关术语, 并联合“中医护理”或“体质护理”或“中医干预”或“辨证护理”等干预措施关键词。通过逻辑运算符“AND”连接核心概念组, 同时限定文献类型为“临床研究”“随机对照试验”“队列研究”“病例对照研究”。	SU=('幽门螺杆菌' OR 'Hp 感染' OR 'HP 感染') AND SU=('阳虚质' OR '阳虚体质' OR '阳虚证' OR '脾肾阳虚' OR '阳气虚衰') AND SU=('中医护理' OR '体质护理' OR '中医干预' OR '辨证护理' OR '中医方案') AND (FT=('临床研究' OR '随机对照试验' OR '队列研究' OR '病例对照研究')))

(续表)

检索工具及方法	具体检索式
(2) PubMed: 结合采用 MeSH 主题词与自由词检索策略。以“ <i>Helicobacter pylori</i> ”为 MeSH 主题词, 扩展其下位词及同义词(如“ <i>H. pylori</i> ”“HP infection”)。结合体质相关术语“Yang-deficiency”“Yang deficiency constitution”及护理干预词“Traditional Chinese Medicine nursing”“constitution-based care”, 通过布尔逻辑运算符“AND”构建检索式。限定文献类型为“clinical trial”“randomized controlled trial”。	("Helicobacter pylori"[MeSH Terms] OR "HP infection"[Title/Abstract] OR "H. pylori"[Title/Abstract]) AND ("Yang-deficiency"[Title/Abstract] OR "Yang-Xu"[Title/Abstract] OR "Yang deficiency constitution"[Title/Abstract] OR "spleen-kidney Yang deficiency"[Title/Abstract]) AND ("Traditional Chinese Medicine"[MeSH Terms] OR "TCM nursing"[Title/Abstract] OR "constitution-based care"[Title/Abstract] OR "syndrome differentiation nursing"[Title/Abstract]) AND ("clinical trial"[Publication Type] OR "randomized controlled trial"[Publication Type] OR "cohort study"[Publication Type])

(2) 文献纳排标准

文献纳入标准: ①纳入标准: 研究对象为 Hp 感染患者; ②涉及 Hp 感染者的全部中医护理的内容; ③研究涉及阳虚质人群所有的中医护理内容; ④证据类型包括指南、系统评价、专家共识和临床随机对照试验。文献排除标准: ①重复发表、数据不完整等文献; ②无法获得全文文献; ③非中文和非英文语言的文章。

1.2.3 文献筛选

筛选方法: 首先, 研究人员通过根据制定的检索策略在相应数据库查找相关文献, 将所有文献均予导入文献管理软件 NoteExpress, 进行查重后删除掉重复文献; 然后, 由 2 名研究生根据纳入排除标准筛选符合条件的文献, 若两人对同一篇文献出现意见分歧时, 请第 3 名资质较高的研究人员介入, 共同讨论, 最终达成共识。

1.2.4 文献质量评价工具

随机对照研究采用 Cochrane 协作网于 2011 年更新的“对于干预性研究进行系统评价的 Cochrane 手册-5.10 版”评价工具^[100]进行评价, 工具包括 7 个条目, 评价者需对每

个项目做出偏倚风险低、偏倚风险高、不清楚的判断，A 级完全满足质量标准，偏倚可能性最小；B 级部分满足质量标准，偏倚可能性为中度；C 级完全不满足质量标准，偏倚可能性最高。

专家共识采用澳大利亚 JBI 循证卫生保健中心（2016）关于专家意见及专家共识类论文的真实性评估工具^[100]，该评价工具由 6 个词条组成，各条目均采用“不清楚”“不适用”“是”“否”进行判断，并且由评价小组讨论决定是否纳入该文献，由 2 名研究者成员进行质量评价，两人意见不一致时通过讨论解决或请第 3 名人员介入判定。

纳入的书籍文献证据质量分级评价标准参照中华中医药学会推荐的方法^[101]进行质量评价，已发布的教材、指南、标准证据级别评定均为一级（见附录 4）。

1.3 结果

1.3.1 纳入文献的一般资料

共检索出相关文献 1140 篇，筛除重复文献 132 篇，根据纳排标准，进一步阅读题目和摘要后剔除与本研究无关的文献 756 篇，文献类型、主题不符数量剔除 223 篇，随后经全文阅读后排除设计不符、文献质量不通过 19 篇，经过双人阅读与筛选，最终本研究共纳入 10 篇文献^[25,27,102-109]，其中随机对照 8 篇^[25,102-108]、专家共识 2 篇^[27,109]，另外通过补充检索共纳入含体质指导的教材 4 本^[59,82,110,111]，文章具体文献筛选流程见图 3-1，纳入文献的一般资料见表 3-3、纳入教材书目具体见表 3-4。

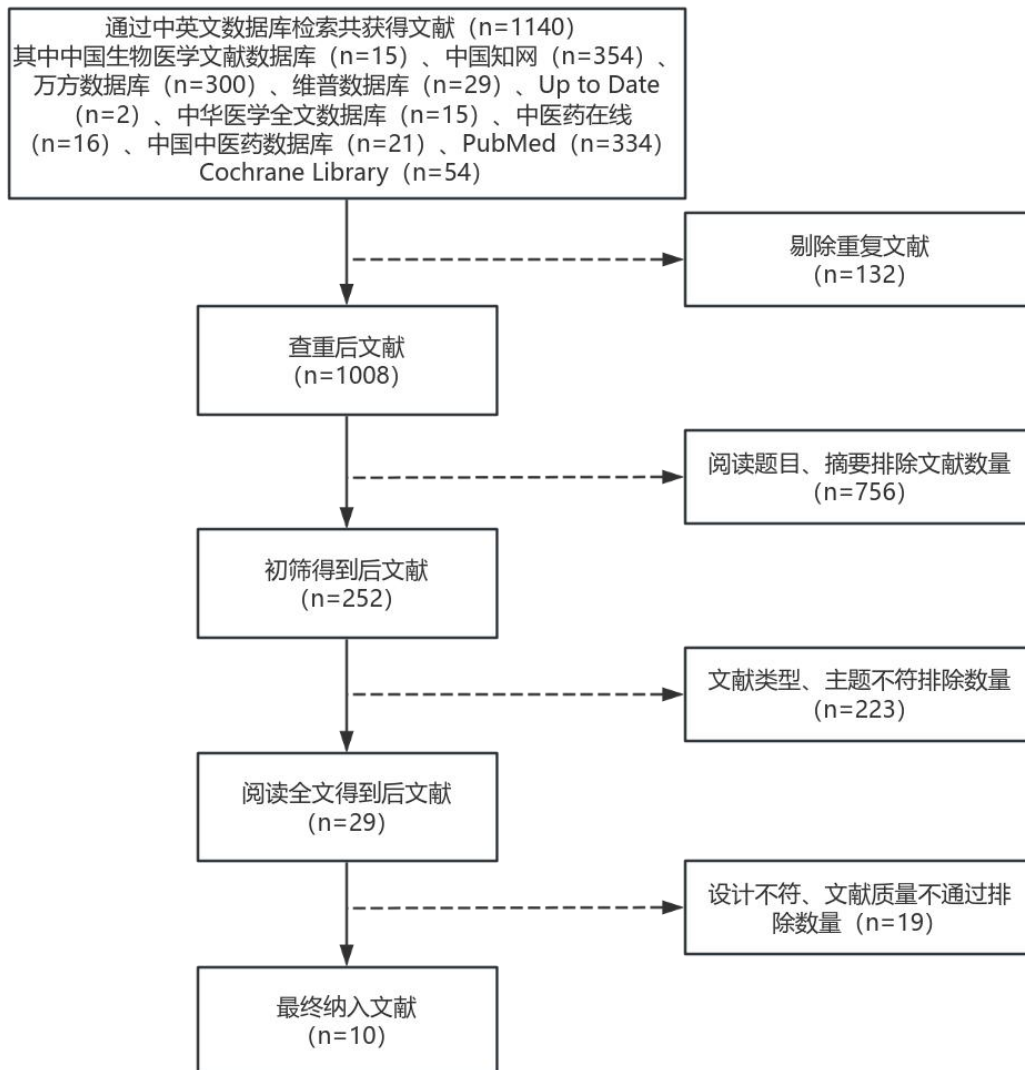


图 3-1 文献筛选流程图

Figure 3-1 Flow chart of literature screening

表 3-3 纳入文献的一般资料

Table 3-3 General Information of Included Literature

纳入文献	文献来源	文献性质	文献主题	发表年份
郭益湘等 ^[25]	CNKI	RCT	辨证施膳结合健康教育在幽门螺杆菌 阳性慢性萎缩性胃炎中的应用	2020
何娟 ^[102]	CNKI	RCT	艾灸大椎穴、神阙穴对阳虚体质调养效 果的临床研究	2021
邓娟娟等 ^[103]	WanFang	RCT	穴位敷贴联合三联疗法对脾胃虚弱型 Hp 相关性胃病的护理效果观察	2021
李贤莉等 ^[104]	CNKI	RCT	中医辨证施护对幽门螺杆菌感染消化 性溃疡患者的干预效果分析	2022
时燕 ^[105]	CNKI	RCT	中医干预对 H.pylori 感染导致胃痛患者 的疗效	2022
吴晓颖 ^[106]	CNKI	RCT	中医辨证施护结合饮食干预对幽门螺 杆菌感染消化性溃疡患者的影响	2019
秦娟文等 ^[107]	WanFang	RCT	中医综合护理配合标准三联疗法对幽 门螺杆菌根除率的影响	2017
周宁 ^[108]	CNKI	RCT	耳穴贴压对十二指肠球部溃疡患者胃 泌素、幽门螺杆菌及生活质量的影响	2012
胡伏莲等 ^[27]	CNKI	专家共识	第二次中国中西医整合治疗幽门螺杆 菌相关“病-证”共识	2024
张学智等 ^[109]	中华医学 全文数据库	专家共识	成人幽门螺杆菌引起的胃炎中西医协 作诊疗专家共识(2020, 北京)	2020

表 3-4 纳入书目表

Table 3-4 List of Included References

书目	作者	出版社	出版时间
中医体质学 ^[59]	王琦	中国中医药出版社	2021
中医基础理论 ^[82]	孙广仁、郑洪新	中国中医药出版社	2020
中医“治未病” ^[110]	孙涛、何清湖	中国中医药出版社	2021
中医护理学 ^[111]	孙秋华	人民卫生出版社	2022

1.3.2 文献质量评价结果

(1) RCT 的质量评价结果

本研究共纳入 8 篇^[25,102-108]随机对照研究，其中 6 篇^[25,102,104-106,108]来源于中国知网，2 篇^[103,107]来自万方数据库，根据偏倚风险进行评价，8 篇质量等级均为 B 级，质量评价结果见表 3-5。

表 3-5 纳入 RCT 的质量评价结果表
Table 3-5 Evaluation Results Table of Quality of Inclusion in RCTs

	郭益湘 等 ^[25]	何娟 [102]	邓娟娟等 [103]	李贤莉 等 ^[104]	时燕 [105]	吴晓颖 [106]	秦娟文等 [107]	周宁 [108]
1.随机序列的产生	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低
2.对随机方案的分配隐藏	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低
3.对研究对象及干预者实施盲法	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	偏倚 风险 低
4.对结果测评者实施盲法	偏倚 风险低	偏倚 风险 低	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚	不 清 楚
5.报告偏倚	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低
6.选择性报告研究结果的可能性	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低
7.其他方面的偏倚来源	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	不 清 楚	偏倚 风险 低	不 清 楚	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低	偏倚 风险 低
质量等级	B 级	B 级	B 级	B 级	B 级	B 级	B 级	B 级

(2) 专家共识评价结果

本研究共纳入 2 篇^[27,109]专家共识，其中 1 篇^[27]来自中国知网，1 篇^[109]来自中华医学全文数据库，两篇专家共识所有评价指标均为“是”，研究设计完整予以纳入，具体评价结果见表 3-6。

表 3-6 纳入专家共识的质量评价结果表

Table 3-6 Table of quality evaluation results included in the expert consensus

纳入文献	1.是否明确标注了观点的来源	2.观点是否来源于该领域有影响力的专家	3.所提出的观点是否与研究相关的人群利益为中心	4.陈述的结论是否是基于分析的结果，观点的表达是否具有逻辑性	5.是否参考了现有的其他文献	6.所提出的观点与以往文献是否有不一致的地方	是否纳入
胡伏莲等 [27]	是	是	是	是	是	是	是
张学智等 [109]	是	是	是	是	是	是	是

(3) 纳入书籍质量评价结果

本研究纳入的 4 本^[59,82,110,111]书籍均为教材，证据质量分级评价标准参照中华中医学学会推荐的方法（见附录 4）进行质量评价，证据级别评定均为一级，均来自学校图书馆典藏书籍，纳入书目质量评价见表 3-7。

表 3-7 纳入书目质量评价结果表

Table 3-7 Included bibliographic quality evaluation results

书目	作者	证据级别
中医体质学 ^[59]	王琦	一级
中医基础理论 ^[82]	孙广仁、郑洪新	一级
中医“治未病” ^[110]	孙涛、何清湖	一级
中医护理学 ^[111]	孙秋华	一级

1.3.3 证据的描述与汇总

本研究利用 JBI 证据分级和证据推荐等级系统（2014）对证据进行了系统检索、提取和整合，该系统将不同研究设计的证据分为五个等级，并根据 FAME 分级原则对证据的可行性、适宜性、临床意义和有效性进行分级，将推荐级别分为 A 级推荐与 B 级推荐^[100]（见附录 5）。最终从体质辨识、调体原则、调体要点、起居调护、精神调摄、饮食调理、运动调理、中医特色疗法 8 个方面总结 16 条证据内容，见表 3-8。

表 3-8 文献证据提取表

Table 3-8 Document evidence extraction table

项目	证据内容	证据等级	推荐级别
体质辨识	1.体质成因：先天不足或后天失养。如孕育时父母体弱，或年长受孕，早产，或年老阳衰等 ^[59, 82] 。	5b	A 级
	2.常见临床表现：面色苍白或目胞晦暗，口唇色淡，不够红润、舌头颜色淡，较胖大，边缘有齿痕、排便不成形、小便清长、脉象沉迟无力、形体多白胖，性格多沉静、内向、易患感冒、关节疼痛、水肿、腹泻等、耐春夏不耐秋冬，易感风、寒、湿邪 ^[59, 82, 110] 。	5b	A 级
调体原则	3.因人施治，权衡制宜，同病异治，异病同治，辩证施护 ^[25, 82] 。	1a	B 级
调体要点	4.温阳佐以养阴，温阳兼顾脾胃，慎用辛热有毒之品 ^[59] 。	5b	A 级
起居调护	5.居住环境：避免在阴暗、潮湿、寒冷的环境下长期工作和生活 ^[59, 104, 111] 。	5b	A 级
	6.生活方式：白天应保持一定的活动量，以微出汗为宜，激发体内阳气，注意保暖，尤其是腰腹、下肢和脚部，根据天气变化及时增减衣物，睡觉前尽量不要饮水，睡前将小便排净，每日睡前用 40~50℃的水泡脚，双脚浸泡 15 分钟左右为宜 ^[59, 111] 。可多晒太阳，但避免过度劳作，防止大汗伤阳 ^[59, 111] 。	5b	A 级
	7.作息习惯：保持规律的作息時間，确保每晚 7~9 小时的睡眠时间，尽量在晚上 10 点前入睡，避免熬夜和不良的生活习惯，以维护身体的生物钟和阳气循环 ^[59, 111] 。	5b	A 级
精神调摄	8.保持阳光心态，加强精神调养 ^[104] ，可以通过听音乐、阅读、与朋友交流等方式舒缓情绪 ^[109] 。多听诸如《黄河大合唱》等激昂、高亢、豪迈的音乐 ^[59] 。	5b	A 级

(续表)

项目	证据内容	证据等级	推荐级别
饮食调摄	9. 建议多摄入温热性质的食物, 如生姜、龙眼、韭菜、花椒等以补充阳气, 避免食用生冷、寒凉、黏腻的食物 ^[59, 82, 109-111] 。 10. 养成良好的饮食习惯: 不饮用生水, 不生吃蔬菜, 聚餐时尽量使用公筷, 家具常消毒, 饭前便后勤洗手 ^[110] 。 11. 饮食有节, 定时定量, 不可过饥过饱, 克服饮食偏嗜, 戒烟戒酒, 五味调配适宜, 不可偏食 ^[59, 110] 。	5b	A 级
运动调理	12. 适度的运动有助于促进血液循环, 增强体内阳气, 建议选择适合自己的运动方式, 如八段锦、快步走等, 运动避风寒 ^[59, 110, 111] 。	5b	A 级
中医特色 疗法	13. 艾灸疗法: 常选择艾灸神阙、气海、关元、中脘、大椎、肾俞、命门等穴位, 选择 3~6 个穴位, 每次艾灸 20 分钟 ^[102] 。 14. 穴位按摩: 选择脾俞、胃俞、中脘、足三里、三阴交, 用拇指、食指点按每个穴位 2~3 分钟, 每天 2 次 ^[107, 111] 。 15. 穴位贴敷: 选中药配以细辛、延胡索、附子、白芥子的中药敷贴, 贴于气海、关元、脾俞、足三里等穴位, 贴敷至 4 小时后撕去敷贴胶布(若有不适可提前撕去), 抹去残留药膏即可, 每天 1 次 ^[105, 111, 112] 。 16. 雷火灸疗法: 可选取神阙、中脘、关元、气海、大椎、百会等, 选择 3~6 个穴位, 每次艾灸 20 分钟, 每天 1 次 ^[111] 。	1c 1c 1c	A 级 A 级 A 级
		1c	B 级

(1) 体质辨识阶段

体质辨识是中医体质护理方案构建的核心前提与关键环节, 其重要性体现在以下三方面: 其一, 体质辨识是“辨体施护”的理论根基。中医强调“因人制宜”, 不同体质者对病原体的易感性、疾病转归及干预反应存在显著差异^[59]。本研究 Hp 感染阳虚质患者因阳气虚弱、脾胃失温, 胃黏膜防御功能低下, 更易形成 Hp 定植的“内寒环境”^[30]。若忽视体质差异, 仅采用传统的西医护理方案(如四联疗法用药指导), 可能因体质偏颇导致疗效受限(如阳虚患者对寒凉药物耐受性差), 甚至加重体质失衡。其二, 体质辨识是个体化健康指导的实践起点。通过标准化体质判定工具, 如《中医体质分类与判定量表》, 可明确患者体质类型及偏颇程度, 从而针对性设计护理措施。

(2) 体质调体遵循的原则与要点

体质调体原则为“同病异治”和“异病同治”，护理上为辨证施护。“同病异治”和“异病同治”是辨证论治的具体体现，同一种疾病，由于体质的差异，在疾病的发展、病机的变化、症状的表现等方面可能存在差异，治疗时应根据不同的情况区别对待；而不同病因或病机的疾病，由于患者的体质在某些方面有共同点，症状随着体质的转变，可出现大致相同的病机变化和症状表现，故可采用大致相同的方法进行治疗^[82]。护理上可进行辨证施膳，例如对于 Hp 感染脾胃湿热证患者在选择饮食时，可选择一些健脾祛湿功效的药膳辅助，如淮山、薏米、白术、莲子、党参等，也可选择清热、除湿的食物，如金银花、菊花、苦瓜、冬瓜、莲藕、鸭肉等；对于脾胃虚弱证的饮食可多吃具有温热健脾作用的食物，如山药、砂仁、扁豆等，少吃苦瓜、西瓜等属于寒凉性的食物^[25]。

（3）精神、饮食、运动、起居等健康教育指导

阳虚质性格沉静、内向，因此要加强精神调养，宜保持积极向上的心态，避免忧思过度损伤阳气，通过精神调养疏肝解郁，助化阳气；饮食指导需温补脾肾，忌食生冷，“寒者热之”，以温性食物为主，固护脾胃阳气。因 Hp 感染传播途径为口-口或粪-口传播，因此仍需注意养成良好的饮食习惯，不饮用生水，不生吃蔬菜，聚餐时尽量使用公筷，家具常消毒，饭前便后勤洗手^[113, 114]。运动方面，适度升阳，动静结合，可每日晨起练习八段锦“两手托天理三焦”“调理脾胃需单举”“五劳七伤往后瞧”“两手攀足固肾腰”四式，每式做 1~3 遍，每周 3~5 次，可调理脾胃，振奋阳气^[59]。起居指导首先环境适宜温和，避免潮湿、阴暗、寒冷等环境下长期工作和生活^[104]，其次注意保暖，养护阳气，可每日睡前用 40~50℃ 的水泡脚，双脚浸泡 15 分钟左右为宜等措施^[59]。方案可综合精神、饮食、运动、起居等调护方式进行健康教育的指导。

（4）干预阶段

Hp 感染中医护理技术的干预措施中，证据 13-16 条建议使用灸法（艾灸或雷火灸）、穴位按摩、穴位贴敷等进行干预，灸法常选择艾灸或雷火灸神阙、气海、关元、中脘、大椎、肾俞、命门等穴位，选择 3~6 个穴位，每次艾灸 20 分钟^[102]；穴位按摩：选择脾俞、胃俞、中脘、足三里、三阴交，用拇指、食指点按每个穴位 2~3 分钟，每天 2 次^[107, 111]；穴位贴敷：选取含细辛、延胡索、附子、白芥子的中药敷贴，贴于气海、关元、脾

俞、足三里等穴位，贴敷至 4 小时后撕去敷贴胶布（若有不适可提前撕去），抹去残留药膏即可，每天 1 次^[105, 112]。这些措施均可通过经络调节全身气机，促进气血生化，调和全身气血，增强脾胃运化，方案可融合“灸-按-贴”三位一体，通过温阳健脾，契合 Hp 感染阳虚质患者的“虚寒”进行调节，对体质护理具有重要意义。

2 构建 Hp 感染阳虚质患者中医体质护理方案初稿

本部分检索、阅读了 Hp 感染患者中医护理干预的相关文献及中医体质护理的相关书籍，通过对纳入文献及书籍内容进行分析、整合及小组讨论后，形成 Hp 感染阳虚质患者中医体质护理方案初稿，包括 8 个一级指标，25 个二级指标，37 个三级指标，共 70 个条目，具体见表 3-9。

表3-9 Hp感染患者阳虚质中医护理方案初稿内容

Table 3-9 Initial draft of TCM nursing plan for Hp infected patients with Yang deficiency		
一级指标	二级指标	三级指标
A. 体质辨识	A1.成因	A1.1 先天不足或后天失养。如孕育时父母体弱，或年长受孕，早产，或年老阳衰等。
		A2.1 面部：面色苍白或目胞晦暗，口唇色淡，不够红润。
	A2. 常见临床表现	A2.2 大便：排便不成形，容易腹泻。
		A2.3 小便：小便清长，尿液颜色较淡，量多，次数频繁。
		A2.4 舌质：舌头颜色淡，较胖大，边缘有齿痕。
		A2.5 脉象：脉象沉迟无力，即脉搏跳动缓慢而无力。
		A2.6 形体：多白胖，肌肉松软。
		A2.7 性格：多沉静、内向。
	A3. 发病倾向	A3.1 易患感冒、关节疼痛、水肿、腹泻等。
	A4.环境适应能力	A4.1 耐春夏不耐秋冬，易感风、寒、湿邪。

(续表)

一级 指标	二级指标	三级指标
B. 调 体 原 则	B1.因人 施治, 权 衡制宜	B1.1 根据患者的个体差异, 包括年龄、性别、生活环境、情志状态、病情特点等诸多因素, 制定出适合该患者的具体调理方法。
	B2.同病 异治, 异 病同治	B2.1 同一种疾病, 由于发病的时间、地域不同, 或所处的疾病阶段或类型不同, 或患者的体质不同, 导致其反映出不同的证候, 因而治疗方法也不一样, 而不同的疾病, 在其发展过程中, 出现了相同的病机, 因而可以采用相同的治法。
	C1.温阳 佐以养阴	C1.1 根据阴阳互根理论, 在温壮元阳的同时, 佐入适量补阴之品, 如熟地黄、山茱萸、山药等, 以达阳得阴助而生化无穷。阳虚者, 用药切忌温阳太过, 以免耗血伤津而转现燥热。因此, 调理阳虚质时要慢温、慢补, 缓缓调治。
C. 调 体 要 点	C2.温阳 兼顾脾胃	C2.1 调治阳虚质有益气、补火之别, 除温壮元阳外, 当兼顾脾胃, 只有脾胃健运, 始能饮食多进, 化源不绝, 体质强健, 亦即养后天以济先天。
	C3.慎用 辛热有毒 之品	C3.1 对于附子之类的有毒温阳药及桂枝、肉桂、干姜之类的辛热温阳药, 一定要在医生的指导下安全使用, 切忌患者自行滥用、误用, 以免出现毒副作用。
	D1.居住 环境	D1.1 避免在阴暗、潮湿、寒冷的环境下长期工作和生活。
D. 起 居 调 护		D2.1 白天应保持一定的活动量, 锻炼以微微出汗为宜, 激发体内阳气。
	D2. 生活 方式	D2.2 注意保暖, 尤其是腰腹、下肢和脚部, 根据天气变化及时增减衣物。 D2.3 睡觉前尽量不要饮水, 睡前将小便排净, 可每日睡前用 40~50℃的水泡脚, 双脚浸泡 15 分钟左右为宜。 D2.4 春夏养阳, 秋冬养阴可多晒太阳, 但避免过度劳作, 防止大汗伤阳。
	D3. 作息 习惯	D3.1 保持规律的作息时间, 确保每晚 7~9 小时的睡眠时间, 尽量在晚上 10 点前入睡, 避免熬夜和不良的生活习惯, 以维护身体的生物钟和阳气循环。
E. 精 神 调 摄	E1.保持 阳光 心态	E1.1 保持积极乐观的心态, 尽量避免和减少悲伤、惊恐等不良情绪影响。
	E2.加强 精神 调养	E2.1 可以通过听音乐、阅读、与朋友交流等方式舒缓情绪。多听诸如《黄河大合唱》等激昂、高亢、豪迈的音乐。

(续表)

一级指标	二级指标	三级指标
F. 饮食调理	F1. 温热性食物摄入	F1.1 建议多摄入温热性质的食物，如生姜、龙眼、肉类（如羊肉、牛肉）、韭菜、花椒等以补充阳气。
	F2. 易消化食物选择	F2.1 选择易消化的食物：适量摄入高蛋白质食物，如小米粥、南瓜粥、蛋等，以确保营养的充分吸收和利用。
	F3. 避免食用生冷、寒凉、黏腻的食物	F3.1 如田螺、螃蟹、苦瓜、香蕉、甘蔗、冰淇淋、冷饮、西瓜、苦瓜、绿豆等，即使在盛夏也不要过食寒凉之品。
	F4. 养成良好饮食习惯	F4.1 不饮用生水，不生吃蔬菜。聚餐时尽量使用公筷，家具常消毒，饭前便后勤洗手。 F4.2 饮食有节，定时定量，不可过饥过饱。 F4.3 克服饮食偏嗜，戒烟戒酒，五味调配适宜，不可偏食。
	F5. 宜食药膳举例	F5.1 当归生姜羊肉汤：温中补血，祛寒止痛。 F5.2 肉桂鸡肝汤：温补肾阳，适合阳虚质易手足发冷、腕腹冷痛者食用。
G. 运动调理	G1. 适当运动	G1.1 适度的运动有助于促进血液循环，增强体内阳气。建议选择适合自己的运动方式，如八段锦，每日晨起将“两手托天理三焦”“调理脾胃需单举”“五劳七伤往后瞧”和“两手攀足固肾腰”共四式练习 1~3 遍，可调理脾胃，振奋阳气，促进阳气的生发和疏通，每周运动 3~5 次。
	G2. 运动避风寒	G2.1 宜在阳光充足的环境下锻炼，根据春夏养阳，最好选择春夏锻炼，冬季避寒就温，春夏多晒太阳，每次不得少于 30 分钟。
H. 中医特色疗法	H1. 艾灸疗法	H1.1 常选择艾灸神阙、气海、关元、中脘、大椎、肾俞、命门等穴位，选择 3~6 个穴位，每次艾灸 20 分钟。有温补肾阳、强身健体的作用。
	H2. 穴位按摩	H2.1 选择脾俞、胃俞、中脘、足三里、三阴交，用拇指、食指点按每个穴位 2~3 分钟，每天 2 次。
	H3. 穴位贴敷	H3.1 选取含细辛、延胡索、附子、白芥子的中药敷贴，贴于气海、关元、脾俞、足三里等穴位，贴敷至 4 小时后撕去敷贴胶布（若有不适可提前撕去），抹去残留药膏即可，每天 1 次
	H4. 雷火灸疗法	H4.1 可选取神阙、中脘、关元、气海、大椎、百会等，选择 3~6 个穴位，每次艾灸 20 分钟，每天 1 次。

3 德尔菲法

德尔菲法 (Delphi method)，又称专家咨询法，是通过数轮问卷咨询专家意见和反馈，就某一主题或事项达成统一意见的方法^[115]。

3.1 遴选函询专家

确定体质护理方案的主要内容后，为保证有效性和可靠性，严格按照德尔菲专家函询的方法、标准，德尔菲法函询专家人数建议在 15~50 人为宜^[116]，适当数量的专家得出的结论具有较高的可信度，本研究考虑专家人数至少为 15 人，函询专家纳入标准如下。

(1) 中医及消化专家具备条件

①来自三级甲等医院；②具有本科或本科以上学历；③具有副高及以上职称；④具有 10 年及以上的消化内科临床或中医科临床工作经验；⑤自愿参与本次专家函询。

(2) 护理专家或专科护士具备条件

①来自三级甲等医院的护理专家或者是护理院校的教师；②大专或大专以上学历；③具有副高及以上或副教授及以上职称；④从事 10 年以上中医护理研究或临床护理研究，有一定的研究积极性；⑤自愿参与本次专家函询。基于上述纳入标准，最终选取 16 名函询专家。

3.2 制作专家咨询问卷

在初步查阅文献和与研究小组讨论的基础上，拟定了阳虚体质 Hp 感染者中医护理方案初稿，并设计了相应的函询问卷（见附录 6），主要包括以下几个部分：

(1) 前言：向专家介绍该研究的题目、内容、目的及填写问卷的时限等。

(2) 专家基本情况：包括年龄、工作领域、职称、职务、学历、是否担任过导师等。

(3) 护理方案专家意见咨询表：包括各级条目重要性评价表和填写方法的说明，评分标准采用 Likert-5 级评分法，从“不重要”到“非常重要”，分值从 1~5 分（1=不重要/不可行，2=不太重要/不太可行，3=中等重要/一般可行，4=重要/可行，5=非常重要/非常可行）。同时，每个条目都有一项备注栏（“更改、增加或删除指标”和“待增加条目”两个空白栏）。

(4) 专家自评表：包含专家对相关内容的熟悉程度和填表时的评判依据。

3.3 函询过程

于 2024 年 8 月至 9 月通过线下发放纸质版或线上发送电子邮件的方式发放函询问卷，并要求专家在 14 天内将完成的问卷返回，于 8 月第一轮所有问卷回收后，通过研究小组讨论，对专家意见进行整理、汇总和修改。在 2024 年 9 月再次形成问卷进行下一轮函询，2 次咨询之间的间隔时间超过 2 周。第二轮专家函询结束后，研究小组对专家意见进行了分析，结果显示专家意见基本一致，结束函询。

3.4 统计学分析

运用 Excel 录入数据，双人录入并核对，用 SPSS27.0 对专家函询结果进行统计分析。专家的基本情况用频数和百分比表示；专家的积极程度用问卷回收率表示，问卷回收率=（回收的问卷数÷发出的问卷数）×100%；专家权威程度用专家权威系数（ Cr ）表示^[117]，权威系数（ Cr ）由判断依据（ Ca ）和熟悉程度（ Cs ）衡量，计算公式为 $Cr = (Ca + Cs) / 2$ ，判断依据包括四个维度，即理论分析、实践经验、同行了解、直观感觉，权威系数越大，表明专家的权威程度越高；专家协调程度通过肯德尔协调系数（ $Kendall's W$ ）和变异系数（ CV ）反映，变异系数越小，表明专家协调程度越高， $Kendall's W$ 值越大且具有显著性（ $P < 0.05$ ），表明专家意见一致性越高^[118]；专家意见的集中程度用条目重要性赋值的均数及满分比表示，值越大，表明专家意见越集中^[119]。

3.5 指标筛选标准

本研究以“指标重要性均数>3.5、变异系数<0.25”作为条目的纳入标准^[120]。结合专家提出的删减、合并、增加或修改意见，由研究小组讨论后决定进行修改完善。

3.6 质量控制

严格按照纳入标准确定函询专家。函询前要提前与函询专家取得联系，说明研究的目的、意义。问卷要简洁清晰，注明填写的要求。适当通过短信及邮件提醒函询专家，提高函询问卷的回收率。运用 Excel 和 SPSS27.0 进行统计分析，双人录入并核对数据，减少录入的误差。

3.7 德尔菲专家函询结果

3.7.1 纳入专家基本情况

本研究中共纳入 16 名专家，均完成 2 轮函询，其中男性 4 名，女性 12 名；年龄以 40~50 岁区间为主，工作年限以 20~30 年居多；专家工作领域主要有消化系统疾病诊治、胃肠道癌症防治、中医“治未病”、中医护理、消化系统疾病护理等。专家一般资料情况详见表 3-10。

表 3- 10 函询专家一般资料表

Table 3- 10 General Information Table for Inquiry of Experts

项目	分组	人数	百分比（%）	
性别	男	4	25.00	
	女	12	75.00	
年龄	<40	3	18.75	
	40-50	8	50.00	
	>50	5	31.25	
工作年限	<20	4	25.00	
	20-30	7	43.75	
	>30	5	31.25	
工作领域	消化系统疾病	是	13	81.25
		否	3	18.75
	胃肠道癌症防治	是	6	37.50
		否	10	62.50
	中医“治未病”	是	8	50.00
		否	8	50.00
	熟悉中医体质调护	是	12	75.00
		否	4	25.00
	熟悉中医护理方案构建	是	7	43.75
		否	9	56.25
职称	副高级	10	62.50	
	正高级	6	37.50	
学历	大专	1	6.25	
	本科	10	62.50	
	硕士	3	18.75	
	博士	2	12.50	
是否担任硕 导及以上	是	6	37.50	
	否	10	62.50	

3.7.2 专家的积极性

专家的积极系数表示专家对研究的合作和重视程度，常用专家咨询问卷的回收率表示，积极系数越高表明专家对研究越重视。计算方法：回收率=每轮回收的问卷数量/每轮发放的问卷总数。两轮专家函询共发放问卷 16 份，回收有效问卷 16 份，有效问卷回收率为 100%，两轮专家函询中，第一轮有 7 名（43.75%），第二轮有 1 名（6.25%）专家提出建议，表明函询专家参与研究的积极性较高，见表 3-11。

表 3-11 两轮专家的积极程度
Table 3-11 Positive level of experts in both rounds

专家函询	发放（份）	回收（份）	提建议人数	提建议率	回收率
第一轮	16	16	7	43.75%	100%
第二轮	16	16	1	6.25%	100%

3.7.3 专家的权威程度

专家权威系数（ Cr ）=（专家判断依据系数 Ca + 专家对条目的熟悉程度系数 Cs ）/2，两轮函询专家判断依据、专家对条目的熟悉程度频数分布具体见表 3-12、3-13。专家对问卷的判断依据赋分情况及专家对问卷熟悉程度的赋分依据情况（见附录 5）。两轮专家函询的权威系数（ Cr ）详见表 3-14。 Cr 值的范围为 0~1，>0.7 说明可接受，>0.8 说明专家的权威程度较高。本研究两轮专家权威系数（ Cr ）均为 0.90，表明函询专家权威程度较高。

表 3-12 专家判断依据频数分布表（频数）
Table 3-12 Frequency distribution of expert judgments (frequency)

判断依据	第一轮			第二轮		
	大	中	小	大	中	小
理论分析	0.3 (14)	0.2 (2)	0.1 (0)	0.3 (13)	0.2 (3)	0.1 (0)
实践或科研经验	0.5 (13)	0.4 (3)	0.3 (0)	0.5 (11)	0.4 (5)	0.3 (0)
对国内外同行的了解或参考资料	0.1 (8)	0.1 (8)	0.1 (0)	0.1 (7)	0.1 (8)	0.1 (1)
直观感觉	0.1 (2)	0.1 (3)	0.1 (11)	0.1 (0)	0.1 (10)	0.1 (6)

表 3-13 专家对问卷熟悉程度频数分布表（频数）

Table 3-13 Frequency distribution of experts' familiarity with the questionnaire (frequency)

熟悉程度	很熟悉	熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉
第一轮	1 (4)	0.8 (11)	0.6 (1)	0.4 (0)	0.2 (0)
第二轮	1 (4)	0.8 (11)	0.6 (1)	0.4 (0)	0.2 (0)

表 3-14 两轮专家的权威系数

Table 3-14 Authority factors for two rounds of experts

	专家判断依据系数 (Ca)	专家对条目的熟悉程度系数 (Cs)	专家权威系数 (Cr)
第一轮	0.96	0.84	0.90
第二轮	0.95	0.84	0.90

3.7.4 专家意见协调程度

专家意见协调程度的衡量指标为变异系数 CV 和 $Kendall$ 协调系数 W ，变异系数 CV 值越小，说明专家之间的协调程度越高，否则就有较大分歧； $Kendal's W$ 系数值在 0~1 范围之内， W 越大，表示协调程度越高， $CV < 0.25$ 为良好指标。本研究第一轮专家函询 W 值为 0.135， CV 值为 0.08~0.29 ($P < 0.05$)；第二轮 W 值为 0.182， CV 值为 0.07~0.19 ($P < 0.05$)，差异具有统计学意义，表明本研究专家意见协调程度较好，见表 3-15。

表 3-15 $Kendall's W$ 系数表Table 3-15 $Kendall's W$ Coefficient

协调程度	$Kendall's W$	χ^2	P
第一轮	0.135	148.719	< 0.001
第二轮	0.182	166.301	< 0.001

3.7.5 专家意见的集中程度

(1) 第一轮专家函询结果

第一轮专家函询所有条目重要性均值 > 3.5 ，变异系数 > 0.25 的条目有 5 个，具体见

表 3-16。根据专家意见，经过课题组成员反复讨论，最终删除条目 9 个条目，修改条目 6 个，增加条目 1 个，具体情况见表 3-17。

表 3-16 第一轮函询专家数据统计表

Table 3-16 Statistics on the first round of consultation with experts

条目	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$) 分	变异系数 (CV)	条目	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$) 分	变异系数 (CV)
A	4.75±0.45	0.09	A2.2	4.56±0.73	0.16
B	4.63±0.50	0.11	A2.3	4.63±0.62	0.13
C	4.06±0.93	0.23	A2.4	4.50±0.63	0.14
D	4.50±0.63	0.14	A2.5	4.69±0.60	0.13
E	4.50±0.73	0.16	A2.6	4.50±0.73	0.16
F	4.69±0.48	0.10	A2.7	4.13±0.89	0.21
G	4.38±0.62	0.14	A3.1	4.19±0.98	0.23
H	4.56±0.63	0.14	A4.1	4.06±0.85	0.21
A1	4.25±0.86	0.20	B1.1	4.81±0.40	0.08
A2	4.56±0.63	0.14	B2.1	4.13±1.15	0.28*
A3	4.19±0.83	0.20	C1.1	4.13±1.20	0.29*
A4	4.06±0.85	0.21	C2.1	4.06±1.18	0.29*
B1	4.81±0.40	0.08	C3.1	4.19±1.17	0.28*
B2	4.13±1.09	0.26*	D1.1	4.06±0.77	0.19
C1	4.38±0.87	0.20	D2.1	4.38±0.72	0.16
C2	4.63±0.50	0.11	D2.2	4.44±0.63	0.14
C3	4.38±0.89	0.20	D2.3	4.00±0.82	0.20
D1	4.19±0.83	0.20	D2.4	4.44±0.81	0.18
D2	4.38±0.72	0.16	D3.1	4.44±0.73	0.16
D3	4.50±0.73	0.16	E1.1	4.44±0.63	0.14
E1	4.44±0.51	0.12	E2.1	4.25±0.68	0.16
E2	4.31±0.60	0.14	F1.1	4.44±0.73	0.16
F1	4.44±0.73	0.16	F2.1	4.38±0.50	0.11
F2	4.38±0.50	0.11	F3.1	4.63±0.50	0.11
F3	4.63±0.50	0.11	F4.1	4.56±0.51	0.11
F4	4.69±0.48	0.10	F4.2	4.44±0.51	0.12
F5	4.38±0.72	0.16	F4.3	4.38±0.72	0.16
G1	4.38±0.62	0.14	F5.1	4.19±0.83	0.20
G2	4.44±0.63	0.14	F5.2	4.19±0.75	0.18

(续表)

条目	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$) 分	变异系数 (CV)	条目	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$) 分	变异系数 (CV)
H1	4.50±0.63	0.14	G1.1	4.38±0.62	0.14
H2	4.44±0.63	0.14	G2.1	4.31±0.70	0.16
H3	4.44±0.63	0.14	H1.1	4.25±0.68	0.16
H4	4.50±0.63	0.14	H2.1	4.38±0.72	0.16
A1.1	4.06±0.77	0.19	H3.1	4.31±0.7	0.16
A2.1	4.69±0.60	0.13	H4.1	4.5±0.63	0.14

注：*为变异系数>0.25。

表 3-17 第一轮专家意见及方案修订表

Table 3-17 The first round of expert opinions and plan revision table

条目	条目内容	专家修改意见	处理方法
C (一级指标)、 C1 (二级指标)、 C2 (二级指标)、 C3 (二级指标)、 C1.1 (三级指标)、 C2.1 (三级指标)、 C3.1 (三级指标)	C: 调体要点 (一级指标) C1: 温阳佐以养阴 (二级指标) C2: 温阳兼顾脾胃 (二级指标) C3: 慎用辛热有毒之品 (二级指标) C1.1: 根据阴阳互根理论, 在温壮元阳的同时, 佐入适量补阴之品, 如熟地黄、山茱萸、山药等, 以达阳得阴助而生化无穷。阳虚者, 用药切忌温阳太过, 以免耗血伤津而转现燥热。因此, 调理阳虚质时要慢温、慢补, 缓缓调治。 (三级指标) C2.1: 调治阳虚质有益气、补火之别, 除温壮元阳外, 当兼顾脾胃, 只有脾胃健运, 始能饮食多进, 化源不绝, 体质强健, 亦即养后天以济先天。 (三级指标) C3.1: 对于附子之类的有毒温阳药及桂枝、肉桂、干姜之类的辛热温阳药, 一定要在医生的指导下安全使用, 切忌患者自行滥用、误用, 以免出现毒副作用。 (三级指标)	这几个条目为同一个一级条目 C 下的子条目内容, 两名专家提到: 护理的项目, 尽量不写药, 且此指标偏向于临床医生的需要考虑的内容措施, 医生才能选方, 此指标有待斟酌, 可删除。	经小组讨论, 接受该意见, 删除该指标, 共 7 个条目。

(续表)

条目	条目内容	专家修改意见	处理方法
B2 (二级指标)、 B2.1 (三级指标)	B2: 同病异治, 异病同治 (二级指标) B2.1: 同一种疾病, 由于发病的时间、地域不同, 或所处的疾病阶段或类型不同, 或患者的体质不同, 导致其反映出不同的证候, 因而治疗方法也不一样, 而不同的疾病, 在其发展过程中, 出现了相同的病机, 因而可以采用相同的治法 (三级指标)	B2.1 为 B2 的子条目内容, 建议将 B2 条目“同病异治, 异病同治”改成“同病异护, 异病同护”描述更合理, 或者建议删除该指标更严谨。	经小组讨论, 接受该意见, 删除该指标, 共 2 个条目。
A2 (二级指标)、 A3 (二级指标)、 F2 (二级指标)、 F2.1 (三级指标)	A2: 常见临床表现 (二级指标) A3: 发病倾向: 易患感冒、关节疼痛、水肿、腹泻等。 (二级指标) F2: 易消化食物选择 (二级指标) F2.1: 选择易消化的食物, 适量摄入高蛋白食物, 如小米粥、南瓜粥、蛋和奶类, 以确保营养的充分吸收和利用 (三级指标)	A2、A3 均为二级指标, 内容有重合, 建议将 A3 指标归入 A2 指标下的三级指标, 不单独列二级指标。同理, 将 F2 并入 F2.1 指标, 内容不变。	经小组讨论, 接收该意见, 将 A3 列入 A2 指标下的三级指标。将 F2 指标归入 F2.1。
H1 (二级指标)、 H4 (二级指标)、 H1.1 (三级指标)、 H4.1 (三级指标)	H1: 艾灸疗法 (二级指标) H4: 雷火灸疗法 (二级指标) H1: 常选择神阙、气海、关元、中脘、大椎、肾俞、命门等穴位, 选择 3~6 个穴位, 每次艾灸 20 分钟。有温补肾阳、强身健体的作用。 (三级指标) H4.1: 可选取神阙、中脘、关元、气海、大椎、百会等, 选择 3~6 个穴位, 每次艾灸 20 分钟, 每天 1 次。 (三级指标)	雷火灸属于灸法中的一类, 建议 H1、H4 合并成一个二级指标, H1、H4 指标下的三级指标 H1.1 和 H4.1 一同合并为同一个三级指标, 且三级指标中建议增加穴位“脾俞”, 脾为后天之本。	经小组讨论, 接受该意见, 合并 H1 与 H4; 合并 H1.1 与 H4.1, 并增加穴位“脾俞穴”。
A2 (二级指标)	A2: 常见临床表现 (二级指标)	建议在 A2 指标下增加一个三级指标, 内容为: 表现精神疲倦、浮肿、舌苔、是否伴有幽门螺杆菌感染相关的症状, 如胃痛、胃胀、反酸等。	经小组讨论, 接受该意见, 增加条目。

(续表)

条目	条目内容	专家修改意见	处理方法
E2.1 (三级指标)	E2.1: 可以通过听音乐、阅读、与朋友交流等方式舒缓情绪。多听诸如《黄河大合唱》等激昂、高亢、豪迈的音乐 (三级指标)	建议从中医五音层面进行指导, 写明选此曲目的依据。	经小组讨论及文献查阅, 接受该意见, 在该指标中增加。
B1.1 (三级指标)	B1.1: 根据患者的个体差异, 包括年龄、性别、体质、生活环境、情志状态、病情特点等诸多因素, 制定出适合该患者的具体调理方法。 (三级指标)	此指标建议描述为: 根据患者的个体差异, 包括年龄、性别、生活环境、情志状态、病情特点等诸多因素, 制定出适合该患者的饮食、情绪、生活方式、中药或艾灸等多种调理方法。	经小组讨论, 接受该意见。
H (一级指标)	H: 中医特色疗法 (一级指标)	建议在该指标下增加耳穴压豆为二级指标, 并增加相应内容的三级指标。	经小组讨论接受该意见。

(2) 第二轮专家函询结果

第二轮专家函询所有条目重要性均值 >3.5 , 变异系数均 <0.25 , 具体见表 3-18。第二轮仅一名专家提出建议, 即在 H2.1 条目中, 穴位按摩增加穴位“涌泉穴”以补肾助阳, 经小组讨论接受本条意见。

表 3-18 第 2 轮函询专家数据统计表

Table 3-18 Statistical table of expert data from the second round of correspondence consultation

条目	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$) 分	变异系数 (CV)	条目	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$) 分	变异系数 (CV)
A	4.88±0.34	0.07	A2.5	4.63±0.62	0.13
B	4.88±0.34	0.07	A2.6	4.56±0.63	0.14
C	4.69±0.48	0.10	A2.7	4.06±0.77	0.19
D	4.81±0.40	0.08	A2.8	4.00±0.73	0.18
E	4.56±0.51	0.11	A2.9	4.19±0.75	0.18
F	4.75±0.45	0.09	A3.0	4.44±0.73	0.16
G	4.81±0.40	0.08	B1.1	4.88±0.34	0.07
A1	4.50±0.52	0.11	C1.1	4.63±0.50	0.11
A2	4.50±0.63	0.14	C2.1	4.38±0.62	0.14
B1	4.88±0.34	0.07	D1.1	4.50±0.52	0.11
C1	4.69±0.48	0.10	D1.2	4.50±0.52	0.11
C2	4.50±0.52	0.11	D1.3	4.63±0.50	0.11
D1	4.56±0.51	0.11	D2.1	4.69±0.60	0.13
D2	4.56±0.63	0.14	D2.2	4.81±0.54	0.11
D3	4.38±0.50	0.11	D3.1	4.56±0.63	0.14
E1	4.56±0.51	0.11	D3.2	4.25±0.77	0.18
E2	4.56±0.51	0.11	D3.3	4.25±0.77	0.18
E3	4.63±0.62	0.13	E1.1	4.50±0.63	0.14
F1	4.63±0.50	0.11	E2.1	4.44±0.51	0.12
F2	4.69±0.48	0.10	E2.2	4.69±0.48	0.10
G1	4.75±0.45	0.09	E2.3	4.25±0.68	0.16
G2	4.69±0.48	0.10	E2.4	4.56±0.63	0.14
G3	4.69±0.48	0.10	E3.1	4.69±0.48	0.10
G4	4.63±0.62	0.13	F1.1	4.63±0.50	0.11
A1.1	4.25±0.77	0.18	F2.1	4.50±0.73	0.16
A2.1	4.75±0.45	0.09	G1.1	4.75±0.45	0.09
A2.2	4.56±0.73	0.16	G2.1	4.56±0.51	0.11
A2.3	4.56±0.51	0.11	G3.1	4.56±0.73	0.16
A2.4	4.31±0.60	0.14	G4.1	4.44±0.81	0.18

4 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案的修订与完善

经过两轮专家函询，根据专家意见和建议，经小组反复讨论修订和完善方案内容，最终形成针对 Hp 感染患者阳虚质中医护理方案终稿内容，包括 7 个维度（一级条目）、17 个子领域（二级条目）、34 项具体干预措施（三级条目），共 58 个条目的标准化护理方案。详见表 3-19。

表 3-19 Hp 感染患者阳虚质中医护理方案终稿

Table 3-19 Final TCM nursing plan for Hp infected patients with Yang deficiency

一级指标	二级指标	三级指标
A. 体 质 辨 识	A1.成因	A1.1 先天不足或后天失养。如孕育时父母体弱，或年长受孕，早产，或年老阳衰等。
		A2.1 表现：常畏寒怕冷、手脚发凉、喜热饮食、睡眠偏多、精神不振，伴幽门螺杆菌感染相关症状，如上腹隐痛、腹胀、嗝气、食欲减退等。
		A2.2 面部：面色苍白或目胞晦暗，口唇色淡，不够红润。
		A2.3 大便：排便不成形，容易腹泻。
	A2. 常见 临床 特征	A2.4 小便：小便清长，尿液颜色较淡，量多，次数频繁。
		A2.5 舌象：舌淡胖嫩，边有齿痕，苔润。
		A2.6 脉象：脉象沉迟无力，即脉搏跳动缓慢而无力。
		A2.7 形体：多白胖，肌肉松软。
		A2.8 性格：多沉静、内向。
		A2.9 发病倾向：易患感冒、关节疼痛、水肿、腹泻等。
		A3.0 环境适应能力：耐春夏不耐秋冬，易感风、寒、湿邪。
B. 调 体 原 则	B1.因人 施治，权 衡制宜	B1.1 根据患者的个体差异，包括年龄、性别、生活环境、情志状态、病情特点等诸多因素，制定出适合该患者的饮食、情绪、生活方式、 中药或艾灸等多种调理方法。

(续表)

一级指标	二级指标	三级指标
C. 精神 调摄	C1.保持 阳光 心态	C1.1 保持积极乐观的心态, 尽量避免和减少悲伤、惊恐等不良情绪影响。
	C2.加强 精神 调养	C2.1 可以通过听音乐舒缓情绪, 诸如《黄河大合唱》等激昂、高亢、豪迈的音乐。《黄河大合唱》属于商调式乐曲, 在中医五音疗法中, 商调式乐曲具有调节肺气的宣发和肃降、养阴保肺、补肾利肝、泻脾胃虚火的功效, 适用于精神不振、形体畏寒的人。 D1.1 宜选用甘温补脾阳、温肾阳为主的食物: 如羊肉、虾、高粱、核桃、龙眼、生姜、韭菜、花椒等, 每周至少食用 3 次温热性食物, 如每周安排 2~3 次羊肉汤、桂圆粥等。
	D1.饮食 宜忌	D1.2 选择易消化的食物: 适量摄入高蛋白质食物, 如小米粥、南瓜粥、蛋等, 以确保营养的充分吸收和利用。 D1.3 避免食用生冷、寒凉、黏腻的食物: 如田螺、螃蟹、苦瓜、香蕉、甘蔗、冰淇淋、冷饮、西瓜、苦瓜、绿豆等。即使在盛夏也不要过食寒凉之品。
	D. 饮食 调理	D2.宜食 药膳举例 D3.养成 良好饮食 习惯 E.1 居住环境
E. 起居 调护	E2. 生活 方式	E1.1 避免在阴暗、潮湿、寒冷的环境下长期工作和生活。 E2.1 白天应保持一定的活动量, 以微微出汗为宜, 激发体内阳气。 E2.2 注意保暖, 尤其是腰腹、下肢和脚部。根据天气变化及时增减衣物。 E2.3 睡觉前尽量不要饮水, 睡前将小便排净, 可每日睡前用 40~50℃ 的水泡脚, 双脚浸泡 15 分钟左右为宜。 E2.4 可多晒太阳, 但避免过度劳作, 防止大汗伤阳。
	E3. 作息 习惯	E3.1 保持规律的作息习惯, 确保每晚 7~9 小时的睡眠时间, 尽量在晚上 10 点前入睡, 避免熬夜和不良的生活习惯, 以维护身体的生物钟和阳气循环。

(续表)

一级指标	二级指标	三级指标
F. 运动 调理	F1.适当 运动	F1.1 适度的运动有助于促进血液循环, 增强体内阳气。建议选择适合自己的运动方式, 如八段锦, 每日晨起将“两手托天理三焦”“调理脾胃需单举”“五劳七伤往后瞧”和“两手攀足固肾腰”共四式练习 1~3 遍, 可调理脾胃, 振奋阳气, 促进阳气的生发和疏通, 每周运动 3~5 次。
	F2.运动 避 风寒	F2.1 宜在阳光充足的环境下锻炼, 根据春夏养阳, 最好选择春夏锻炼, 冬季避寒就温, 春夏多晒太阳, 每次不得少于 30 分钟。
	G1. 灸法	G1.1 常选择艾灸或雷火灸进行神阙、气海、关元、中脘、大椎、肾俞、脾俞、命门等穴位灸疗, 选择 3~6 个穴位, 每天 1 次, 每次艾灸 20 分钟, 有温补肾阳、强身健体的作用。
	G2.穴位 按摩	G2.1 选择中脘、神阙、气海、关元、足三里、三阴交、涌泉等, 用拇指、食指点按每个穴位 2~3 分钟, 每天 2 次。
G.中医 特色 疗法	G3.穴位 贴敷	G3.1 选取含细辛、延胡索、附子、白芥子的中药敷贴, 贴于气海、关元、脾俞、足三里等穴位, 贴敷至 4 小时后撕去敷贴胶布(若有不适可提前撕去), 抹去残留药膏即可, 每天 1 次。
	G4.耳穴 压豆	G4.1 主穴: 胃、肾、脾、神门、肺、大肠。失眠多梦、心神不宁者加心、小肠、胸; 头晕目眩、情绪抑郁者加肝、结节、三焦; 消化道不适加十二指肠、小肠、消化系统皮质下等。将王不留行籽耳贴贴于一侧耳穴, 告知患者每日按压 3~5 次, 每次每穴按压 1~2 分钟, 每 3 天更换 1 次, 每次贴压 5~7 穴为宜, 两耳交替贴压。

5 讨论

5.1 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的必要性

Hp 感染率高，是全球性的公共卫生问题，与多种胃部疾病密切相关^[2,5,9]。虽然目前研究有较为成熟的四联疗法等西医治疗，但其复发率和抗生素耐药率也逐渐增加^[10,11]，中医护理在 Hp 感染的防治方面展现出独特的优势和潜力，其中中医体质学作为研究人体“偏颇体质”与疾病易感性关联的独特理论体系，为探索 Hp 感染的宿主因素提供了新视角^[20]，中医体质学说强调体质的可调性，认为通过对偏颇体质的护理，可促进机体恢复健康，增加机体防病抗病能力^[21]。经过分析前期病例对照的研究结果发现，阳虚质作为偏颇体质，是本研究中 Hp 感染的首要危险体质因素，其体质使机体发生 Hp 感染的风险性增加，这启示我们可从该偏颇体质出发，通过分析该体质的成因、特点以及总结相应的中医护理调理方法，为 Hp 感染阳虚质患者提供个性化的中医护理方案，旨在推动中医特色护理在 Hp 感染防治中的广泛应用和创新发展。

5.2 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的科学性

中医体质学说强调体质的可调性，本研究通过病例对照研究证实阳虚质与 Hp 感染显著相关，为本研究 Hp 感染的首要危险体质因素（ $OR=3.21$ ， $P<0.05$ ），可能的原因为阳虚质人群脾胃功能较弱，较易出现消化不良、胃痛等症状，这可能为 Hp 的生长繁殖提供了适宜的环境，脾胃虚弱是其发病的根源，因此该体质比例更高^[30]。明确该危险体质因素后，便以寻找体质护理的相关内容，使体质护理方案的构建更具针对性。下一步进行文献回顾，系统性检索国内外关于 Hp 感染相关中医护理及阳虚质相关护理的研究，补充检索图书馆相关教材文献，进行文献质量评价及证据总结，结合 Hp 感染患者的相关性，进一步探讨并确定方案框架。基于体质可调理论和脏腑经络学说依据、量性研究及文献回顾的结果，研究小组讨论后形成方案初稿，经过两轮专家函询，选取从事消化内科、中医科及熟悉中医体质调护及中医“治未病”等方面的专家，专家积极性均为 100%，权威系数均在 0.9，提示专家咨询较为可靠，根据专家意见进行修改，研究小组进行讨论，最终形成方案修订稿，整个护理方案构建过程严谨规范，具有科学性。

5.3 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的合理性

本研究的量性研究结果显示，阳虚质是 Hp 感染患者的危险体质因素，根据 Hp 感染及阳虚质相关文献回顾，融合现代循证证据总结方法，构建了兼具理论深度与实践价值的中医体质护理方案，为 Hp 感染的个体化管理提供参考依据。构建的体质护理方案从体质辨识、调体原则、精神调摄、饮食调理、起居调理、运动调理及中医特色疗法 7 方面进行归纳总结，最终形成 7 个维度（一级条目）、17 个子领域（二级条目）、34 项具体干预措施（三级条目）的标准化护理方案。该护理方案内容宣教简单、方便，中医特色疗法简单易行，较易接受，具有一定的合理性。

5.4 幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案构建的适用性

本研究经过病例对照研究结果所构建的 Hp 感染阳虚质中医护理方案，将体质辨识与 Hp 感染的护理结合，弥补了 Hp 感染传统西医护理缺少针对个体体质护理的不足，用于针对 Hp 感染阳虚质患者进行的体质护理，未来需通过大样本研究进一步验证其普适性。

不足与展望

创新性：与传统的护理健康教育模式不同，本研究构建的 Hp 感染护理方案是基于中医体质的护理，从个体的偏颇体质入手，构建的个性化体质护理方案。

不足：（1）体质判定客观化不足，本研究根据中医体质量表进行体质评定，缺乏客观指标评定，未来本研究仍需进一步探索，增加红外线热成像等客观指标的辅助评价以使研究结果更加充实。（2）由于体质调理周期较长，加之人力物力的限制，本研究构建的幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案缺乏临床实践验证，因此后续可进一步开展应用，观察应用后患者阳虚质转化分及中医症候积分等改善情况。

展望：（1）开发体质客观化判定体系，例如整合代谢组学与微生物组特征，构建阳虚质生物标志物组合等。（2）本研究构建的幽门螺杆菌感染患者阳虚质中医护理方案后续可开展临床应用研究，以观察体质改善效果。（3）探索智慧中医护理模式，例如开发 AI 体质辨识小程序，构建个性化体质护理方案推荐系统。

结 论

1. 本研究提示幽门螺杆菌感染与中医体质存在相关性，阳虚质是幽门螺杆菌感染的首要危险体质因素，平和质为保护因素；
2. 基于德尔菲法构建的幽门螺杆菌感染患者阳虚质护理方案构建过程严谨规范，具有科学性，咨询结果可靠，具有合理性。

参考文献

- [1] 王雪宁. 幽门螺杆菌 (Hp) 相关性慢性胃炎的中医证素分布规律研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2020.
- [2] Katelaris P, Hunt R, Bazzoli F, et al. Helicobacter pylori World Gastroenterology Organization Global Guideline[J]. Journal of Clinical Gastroenterology, 2023,57(2):111-126.
- [3] 朱红梅, 刘颖初, 薛元, 等. 2012—2022 年中国幽门螺杆菌流行病学 Meta 分析[J]. 预防医学情报杂志, 2023,39(9):1124-1137.
- [4] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南[J]. 胃肠病学, 2022,27(03):150-162.
- [5] Aumpan N, Vilaichone R, Nunanan P, et al. Predictors for development of complete and incomplete intestinal metaplasia (IM) associated with H. pylori infection: A large-scale study from low prevalence area of gastric cancer (IM-HP trial)[J]. PLOS ONE, 2020,15(10):e239434.DOI:10.1371/journal.pone.0239434.
- [6] Endo K, Nakada H, Kadota Y, et al. Risk factors for atrophic gastritis in the Japanese young and middle-aged: a study using double-contrast upper gastrointestinal barium X-ray radiography.[J]. JPN J RADIOL, 2018,36(12):706-711.
- [7] Aumpan N, Mahachai V, Vilaichone R K. Management of Helicobacter pylori infection[J]. JGH Open, 2023,7(1):3-15.DOI:10.1002/jgh3.12843.
- [8] Blaser M J. Intrastrain differences in Helicobacter pylori: a key question in mucosal damage?[J]. Ann Med, 1995,27(5):559-563.
- [9] 谢嘉敏. 生活习惯及体质因素与幽门螺旋杆菌感染的相关性研究[D]. 湖南: 湖南中医药大学, 2018.
- [10] 胡奕, 祝荫. 幽门螺杆菌感染治疗的规范化管理[J]. 中国实用内科杂志, 2023,43(4):292-295.

- [11] Zhong Z, Zhang Z, Wang J, et al. A retrospective study of the antibiotic-resistant phenotypes and genotypes of *Helicobacter pylori* strains in China[J]. American journal of cancer research, 2021,11(10):5027-5037.
- [12] 陈署洪, 吕冠华. 中西医治疗幽门螺杆菌感染研究进展[J]. 中外医学研究, 2023,21(5):175-180.DOI:10.14033/j.cnki.cfmr.2023.05.044.
- [13] 梁雨, 王启斌, 和水祥. 铋剂临床应用进展[J]. 临床医学研究与实践, 2018,31(31):194-196.
- [14] 中华医学会健康管理学分会, 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组, 编辑委员会中华健康管理学杂志. 体检人群幽门螺杆菌感染筛查与管理专家共识[J]. 中华健康管理学杂志, 2024,18(8):561-570.
- [15] 吴佳栩. 幽门螺杆菌感染患者症状特征与中医体质相关性研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2021.
- [16] 游佳琪. 幽门螺杆菌感染的中医体质分布及相关危险因素分析[D]. 黑龙江: 黑龙江中医药大学, 2022.
- [17] 陈瑶, 袁宏勋, 叶晖, 等. 基于倾向得分匹配的幽门螺杆菌根治失败患者中医证型及舌象分布研究[J]. 中国中医基础医学杂志, 2021,27(6):986-989.
- [18] 祁松, 钱洋, 潘晋方. 体检人群幽门螺杆菌感染与中医体质、糖脂代谢相关性研究[J]. 安徽中医药大学学报, 2023,42(02):18-21.
- [19] 马倩, 李敏, 张玉玲, 等. 应用中医体质学说对临床护士体质辨识与干预研究[J]. 中国实用护理杂志, 2016,32(32):2533-2535.
- [20] 李京尧, 王盼, 刘文静, 等. 幽门螺杆菌相关性胃炎患者中医体质与中医证型相关性研究[J]. 时珍国医国药, 2020,31(10):2416-2418.
- [21] 王琦. 中医体质三论[C]//: 中华中医药学会第六届 中医体质学术研讨会暨 2008 年国际传统 医药创新与发展态势论坛, 2008.
- [22] 林娟, 李园, 王丽媛, 等. 循证护理对老年幽门螺旋杆菌感染患者疗效的影响[J]. 中华医院感染学杂志, 2017,27(23):5498-5500.

- [23] 施绍龙, 曹金霞, 何渝煦. 扶正温阳法对阳虚质免疫功能的影响[J]. 实用中医内科杂志, 2021,35(4):30-33.
- [24] 马刚, 张西青, 马臻, 等. 黄芪建中汤联合合募配穴灸法辅助治疗脾胃虚寒型幽门螺杆菌阳性慢性萎缩性胃炎的疗效观察[J]. 中华养生保健, 2024,42(15):16-19.
- [25] 郭益湘, 马鹏莉, 杨霞, 等. 辨证施膳结合健康教育在幽门螺杆菌阳性慢性萎缩性胃炎中的应用[J]. 实用中医内科杂志, 2020,34(8):92-95.
- [26] 黄洪图, 贺娟, 校注. 黄帝内经素问[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021.
- [27] 胡伏莲, 张声生, 张学智, 等. 第二次中国中西医整合治疗幽门螺杆菌相关“病-证”共识[J]. 胃肠病学和肝病杂志, 2024,33(12):1581-1588.
- [28] 王济, 郑燕飞. 中医体质营养学[M]. 1. 中国中医药出版社, 2020: 359.
- [29] 胡玉乐, 张治祥, 李毅, 等. 基于体质及其证候分型探讨幽门螺旋杆菌感染的防治[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2020,22(4):1083-1087.
- [30] 赵海虹, 梁敏丽, 卢秀霞, 等. 基于脾胃学说探讨中医体质与肠道菌群的关系[J]. 中华中医药杂志, 2022,37(12):7106-7109.
- [31] 中华中医药学会. 中医体质分类与判定[S]. 世界中西医结合杂志, 2009.
- [32] 胡文悦, 韩振蕴, 王振亦, 等. 抑郁障碍与中医体质相关性研究的系统评价和 Meta 分析[J]. 世界中医药, 2023,18(14):1986-1994.
- [33] 梁洁欣, 冯跃, 李健忠等. 中医体质智能辨识方法的研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2024:1-28.
- [34] 袁敏, 陈卓, 徐冰青. 面向数据特征的人机物融合服务分派方法[J]. 软件学报, 2021,32(11):3404-3422.
- [35] 曹文灿, 蒋明君, 李林霜, 等. 鼻鼾常见体质的三辨诊疗模式及方药应用[J]. 时珍国医国药, 2020,31(10):2458-2460.
- [36] 王琦. 从三个关键科学问题论中医体质学的进展及展望* — 中华中医药学会中医体质分会第十九次学术年会讲话[J]. 北京中医药大学学报, 2021,44(12):1061-1066.

- [37] 蔡煜阳, 李竹青, 杨帆, 等. 中医体质辨识客观化研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2024,39(12):6611-6615.
- [38] 刘慧, 刘松涛, 张华芳. 中医九种体质与幽门螺杆菌感染阳性率的相关性研究[J]. 临床医学工程, 2021,28(2):157-158.
- [39] 王美蓉, 林艳, 徐训贞, 等. 幽门螺杆菌感染患者中医体质类型分布及易感因素分析[J]. 中国民间疗法, 2019,27(24):57-60.
- [40] 潘慧人, 黄深荣, 邹铭斐. 600 例幽门螺杆菌感染者中医体质分析[J]. 中医临床研究, 2014(4):20-21.
- [41] 龙科言, 熊文晓, 赵曼羽, 等. 幽门螺杆菌在环境和口腔检出现状及传播途径研究进展[J]. 现代预防医学, 2023,50(11):2107-2112.
- [42] 益明辉. 中医与泰医体质学说比较及泰国 2 型糖尿病中医体质分布的研究[D]. 长春: 长春中医药大学, 2022.
- [43] Zhang T, Luo H, Wei D, et al. Traditional Chinese Medicine Constitution Correlated with Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2021,2021:1-11.DOI:10.1155/2021/5524925.
- [44] Bai F, Luo H, Wang L, et al. A Meta-Analysis of the Association between Diabetes Mellitus and Traditional Chinese Medicine Constitution[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2021,2021:1-14.DOI:10.1155/2021/6390530.
- [45] Mu T, Zhu Q, Chen L, et al. Traditional Chinese Medicine constitution types of high-normal blood pressure: A meta-analysis[J]. Heliyon, 2023,9(2):e13438.DOI:10.1016/j.heliyon.2023.e13438.
- [46] Jiang Z, Chen J, You Y, et al. The Correlation between Traditional Chinese Medicine Constitution and Hyperuricemia and Gout: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2023,2023(1).DOI:10.1155/2023/5097490.
- [47] Yap S Y, Ng F L, Subramaniam M, et al. Traditional Chinese Medicine Body

- Constitutions as Predictors for Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Behavioral Sciences, 2022,12(11):423.DOI:10.3390/bs12110423.
- [48] Yu X, Yan L, Lan Q, et al. Correlation between TCM Constitutional Types and Lung Carcinoma in Various Geographical Areas: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Contrast Media & Molecular Imaging, 2022,2022(1):1-12.DOI:10.1155/2022/5660231.
- [49] 苏春芝. 基于 CiteSpace 的拔罐法临床护理应用文献计量学分析[J]. 护理研究, 2024,38(14):2628-2632.
- [50] Guarneri C, Ceccarelli M, Rinaldi L, et al. Helicobacter pylori and skin disorders: a comprehensive review of the available literature[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2020,24(23):12267-12287.
- [51] 张笑科. 公众对幽门螺旋杆菌的认知和预防治疗行为调查[J]. 中国新通信, 2019,21(7):243-244.
- [52] 王闫. 幽门螺杆菌感染患者管理现状及一般人群认知情况调查研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2022.
- [53] 王莹鑫, 邹金宇, 胡利凤, 等. 一般人群幽门螺杆菌认知现况调查[J]. 中国初级卫生保健, 2022,36(1):60-65.
- [54] 查菁. 强化患者教育对幽门螺杆菌根除治疗影响的研究[D]. 济南: 山东大学, 2022.
- [55] Lee J W, Kim N, Nam R H, et al. Favorable outcomes of culture-based Helicobacter pylori eradication therapy in a region with high antimicrobial resistance[J]. Helicobacter, 2019,24(2).DOI:10.1111/hel.12561.
- [56] 毛家琪, 庄丽维. 幽门螺杆菌感染的诊疗进展[J]. 医学综述, 2020,26(21):4253-4257.
- [57] 曾会萍, 曾美男. 中医综合护理干预辅助治疗幽门螺杆菌相关性胃炎疗效观察[J]. 中西医结合护理 (中英文), 2017,3(2):58-60.
- [58] 丁嘉妮, 胡峰, 郁培, 等. 中医特色护理对幽门螺杆菌相关性胃炎的护理效果[J].

中外医疗, 2023,42(35):143-146.

[59] 王琦. 中医体质学[M]. 北京: 北京中医药出版社, 2021: 78-79.

[60] 姚渊, 马晓北. 调节脾胃阳气在“治未病”中的核心作用及其具体应用探讨[J]. 中国中医基础医学杂志, 2022,28(03):343-346.

[61] 王琦, 朱燕波. 中国一般人群中中医体质流行病学调查——基于全国 9 省市 21948 例流行病学调查数据[J]. 中华中医药杂志, 2009,24(01):7-12.

[62] 冯娟, 宫玉艳, 李好勋, 等. 全国五省市一般人群中中医体质流行病学调查[J]. 中华中医药杂志, 2016,31(11):4722-4725.

[63] 旭张, 雪杨, 于慧娟. 阳虚质相关疾病及临床干预的研究概况[J]. 按摩与康复医学, 2023,14(11):89-93.

[64] 罗辉, 李英帅, 李竹青, 等. 阳虚质与疾病的相关性——基于 214 项临床研究的文献计量分析[J]. 中医杂志, 2020,61(08):716-720.

[65] 高惠贤, 李岩, 吴涛涛, 等. 阳虚体质与抑郁障碍的关系解析[J]. 中华中医药杂志, 2021,36(08):4857-4859.

[66] 王琦. 中医体质学在大健康问题中的应对与优势[J]. 北京中医药大学学报, 2021,44(3):197-202.

[67] 杨燕, 梁雨晴, 曹鑫馨, 等. 基于“体病相关-体质可调”理论探析老年慢病防治策略[J]. 中华中医药杂志, 2022,37(03):1556-1559.

[68] 陈兰兰, 王益平, 卢兴凤, 等. 中医体质护理门诊的建立及实践[J]. 中华护理杂志, 2018,53(5):584-587.

[69] 纪燕平, 冯晓菲, 韩晶. 基于中医体质辨识的健康教育在提高内科患者生活质量中的作用[J]. 中医药管理杂志, 2023,31(1).

[70] 陆柳营, 杨连招, 陈玲, 等. 拔罐疗法对社区痰湿质老年高血压患者中医体质调理效果研究[J]. 中国实用护理杂志, 2021,37(28):2167-2176.

[71] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告（非根除治疗部分）[J]. 胃肠病学, 2022,27(5):289-304.

- [72] 李焱, 李源化, 李苏华, 等. 西宁地区 2730 例健康体检者幽门螺杆菌感染情况分析[J]. 山东医药, 2023,63(06):78-81.
- [73] 李春草. 基于脏腑经络学说的《伤寒杂病论》气逆病证辨治规律研究[D]. 济南: 山东中医药大学, 2022.
- [74] 梁钰莹, 万宛若, 谢滢, 等. 中药复方及成分改善再生障碍性贫血机制研究进展[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2025,27(1):168-178.
- [75] 彭忠海. 紫荆止痛贴治疗急性踝关节扭伤的临床研究及对血清炎性因子的影响[D]. 广州: 广州中医药大学, 2021.
- [76] 孙振球, 徐勇勇. 医学统计学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2014: 532-535.
- [77] 朱丽冰. 成人版《中医体质分类与判定》标准及《中医体质量表》修订[D]. 北京: 北京中医药大学, 2017.
- [78] 张旭, 杨雪. 阳虚质相关疾病及临床干预的研究概况[J]. 按摩与康复医学, 2023,14(11):89-93.
- [79] 蒲明路. 《黄帝内经》宇宙观的三个维度[J]. 文化学刊, 2023(05):94-97.
- [80] 连丽娟. 中医体质类型与慢性胃炎病理分型的相关性[J]. 中国民间疗法, 2020,28(7):63-65.
- [81] 郑翊轩, 白光. 慢性萎缩性胃炎患者中医体质类型分布特点[J]. 临床军医杂志, 2020,48(07):804-805.
- [82] 孙广仁, 郑洪新. 中医基础理论[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2020: 194-200.
- [83] 李珊珊. 闽南地区慢性乙肝患者中医体质特点及其与理化指标的关系[D]. 福州: 福建中医药大学, 2019.
- [84] 朱晶晶, 张扬, 龚小会, 等. 基于人工智能算法与中医体质类型的老年糖尿病患者合并心血管疾病预测模型[J]. 上海中医药杂志, 2025,59(3):1-6.
- [85] 钟伟琴, 李丙生, 许岸高. 阳虚型功能性胃肠病肠道菌群的差异性研究[J]. 现代消化及介入诊疗, 2023,28(05):607-613.
- [86] 张栋, 张彩凤, 周芳, 等. 从“脾胃湿热”理论探讨机体感染幽门螺杆菌环境的形成

- [J]. 云南中医中药杂志, 2023,44(12):20-22.
- [87] 于欣, 李天星, 白帆, 等. 基于文献对全国七个地理区划中医体质类型构成情况的分析[J]. 中国医药科学, 2021,11(14):151-154, 158.
- [88] 李晓文, 韩双双, 仁罗. 阳虚体质影响因素的研究进展[J]. 中国中医基础学杂志, 2020,26(10):1574-1577.
- [89] 王俞铎, 陈昊昱, 任雪童, 等. 基于病因学理论探讨肠道菌群失调之六淫属性[J]. 北京中医药大学学报, 2023,46(12):1658-1664.
- [90] 张昌云, 景彩, 肖宁, 等. 16S rDNA 基因测序分析阳虚质人群肠道菌群特征的研究[J]. 山东中医杂志, 2020,39(07):697-703.
- [91] 王雨, 赵薇巍, 姚玉璞, 等. 中医体质类型与慢性萎缩性胃炎相关性研究的系统评价与Meta 分析[J]. 世界中西医结合杂志, 2022.
- [92] 杨艺. 消化性溃疡中医体质分布与证型的相关性研究 [D]. 济南: 山东中医药大学, 2020.
- [93] 孙陶陶. 功能性消化不良舌面脉象与体质特征的规律研究[D]. 安徽: 安徽中医药大学, 2020.
- [94] 赵鹏飞. 不同中医体质人群外周血 TCR 免疫组库分析和定量蛋白质组学研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2020.
- [95] 陈君怡, 唐莉, 缪伟峰, 等. 结直肠腺瘤/腺癌阳虚体质与免疫功能相关性的研究进展[J]. 中医药临床杂志, 2025,37(03):582-587.
- [96] 周琼, 安明伟, 唐勇, 等. 浅析阳虚质与肠道菌群的相关性[J]. 江西中医药大学学报, 2023,35(1):20-23.
- [97] 喜张, 朱佳杰, 潘华峰, 等. 从“脾—肠道微生态”探讨中医药治疗慢性胃炎新机制[J]. 时珍国医国药, 2024,35(3):695-697.
- [98] 徐宝玲. 针刺结合气交灸治疗阳虚质慢性疲劳综合征临床观察[D]. 广州: 广州中医药大学针灸推拿学, 2023.
- [99] 周艳华. 功能性消化不良患者中医证型与中医体质及相关影响因素的研究[D]. 昆

明: 云南中医药大学, 2023.

- [100] 胡雁, 郝玉芳. 循证护理学[M]. 2. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 55-83.
- [101] 贾倩男. 《产褥期妇女食养药膳技术指南》的研制[D]. 天津: 天津中医药大学, 2020.
- [102] 何娟. 艾灸大椎穴、神阙穴对阳虚体质调养效果的临床研究[D]. 南宁: 广西中医药大学, 2021.
- [103] 邓娟娟, 邓琼琪, 罗尧岳. 穴位敷贴联合三联疗法对脾胃虚弱型 Hp 相关性胃病的护理效果观察[J]. 湖南中医杂志, 2021,37(6):94-96, 177.
- [104] 李贤莉, 易平, 严群, 等. 中医辨证施护对幽门螺杆菌感染消化性溃疡患者的干预效果分析[J]. 时珍国医国药, 2022,33(09):2192-2194.
- [105] 时燕. 中医干预对 H. pylori 感染致胃痛患者的疗效[J]. 河北医药, 2022,44(15):2340-2342.
- [106] 吴晓颖. 中医辨证施护结合饮食干预对幽门螺杆菌感染消化性溃疡患者的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2019,23(14):25-28.
- [107] 秦娟文, 郑超伟, 石丹梅, 等. 中医综合护理配合标准三联疗法对幽门螺杆菌根除率的影响[J]. 护理研究, 2017,31(28):3564-3566.
- [108] 周宁. 耳穴贴压对十二指肠球部溃疡患者胃泌素、幽门螺杆菌及生活质量的影响[D]. 福州: 福建中医药大学, 2012.
- [109] 张学智, 魏玮, 蓝宇. 成人幽门螺杆菌引起的胃炎中西医协作诊疗专家共识(2020, 北京)[J]. 中医杂志, 2020,61(22):2016-2024.
- [110] 何清湖孙涛. 中医“治未病”[M]. 2. 北京: 中国中医药出版社, 2021.
- [111] 孙秋华. 中医护理学[M]. 5. 北京: 人民卫生出版社, 2022: 133-134.
- [112] 邓娟娟, 邓琼琪, 罗尧岳. 穴位敷贴联合三联疗法对脾胃虚弱型 Hp 相关性胃病的护理效果观察[J]. 湖南中医杂志, 2021,37(6):94-96, 177.
- [113] 林华琴, 黄美娜, 李碧真. 自我行为与饮食护理干预对幽门螺杆菌感染患者自我效能与预后的影响[J]. 吉林医学, 2023,44(7):2003-2005.

- [114] 赖永康, 周显祝, 杜奕奇, 等. 中国家庭幽门螺杆菌感染防治策略[J]. 海军军医大学学报, 2025,46(1):1-7.
- [115] 胡雁, 王志稳. 护理研究[M]. 5. 北京: 人民卫生出版社, 2021: 156-158.
- [116] 张先庚, 刘珊, 刘林峰, 等. 基于德尔菲法构建初级医养结合老年护理人才岗位胜任力评价指标体系[J]. 解放军护理杂志, 2022,39(3):24-27.
- [117] 向俊辉. 骨质疏松症患者就医延迟的质性研究及其护理干预方案构建[D]. 武汉: 湖北中医药大学, 2023.
- [118] 邵雅双, 苏倩, 吴白女, 等. 中医护理方案实施质量评价体系的构建[J]. 中华护理杂志, 2024,59(18):2244-2250.
- [119] 耿晴晴, 王晓, 姚海玲, 等. 创伤性脊髓损伤病人出院准备度干预方案的构建[J]. 护理研究, 2025,39(04):559-564.
- [120] 王之惠, 郝帅, 白晓温, 等. 基于保护动机理论糖尿病视网膜病变患者健康教育方案的构建[J]. 中华护理杂志, 2023,58(10):1185-1191.

附录

附录 1

一般资料调查表

1. 性别：☐男 ☐女
2. 年龄： 岁
3. 民族： 族
4. 婚姻状况：☐未婚 ☐已婚 ☐离异 ☐丧偶
5. 籍贯：
6. 职业：☐工人 ☐学生 ☐农民 ☐商业及服务业人员 ☐专业技术人员
 ☐行政管理人员 ☐离退休 ☐其他
7. 文化程度：☐初中及以下 ☐高中/中专 ☐大专/本科 ☐硕士及以上
8. 居住条件：☐城市 ☐农村
9. 居住状况：☐独居 ☐与配偶居住 ☐与子女居住 ☐与父母居住
10. 家庭人均月收入(元) ☐<1000 ☐1000~2000 ☐2000~3000 ☐>3000
11. Hp 检测：☐阴性 ☐阳性
12. 填表日期： 年 月 日

附录 2

成人版《中医体质量表》

本问卷是为了调查与您的体质有关的一些情况，从而为今后的健康管理和临床诊疗等提供参考。请逐项阅读每一个问题，根据自己近一年来的实际情况或感觉，选择最符合您的选项圈“○”。如果某一个您不能肯定如何回答，就选择最接近您实际情况的那个答案。

请注意所有问题都是根据您近一年的情况作答，而且每一个问题只能选一个答案。

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您精力充沛吗？	1	2	3	4	5
(2) 您容易疲乏吗？*	1	2	3	4	5
(3) 您容易气短（呼吸短促，接不上气）吗？	1	2	3	4	5
(4) 您容易心慌吗？	1	2	3	4	5
(5) 您容易头晕或站起时晕眩吗？	1	2	3	4	5
(6) 您喜欢安静、懒得说话吗？	1	2	3	4	5
(7) 您说话声音低弱无力吗？*	1	2	3	4	5
(8) 您感到闷闷不乐、情绪低沉吗？*	1	2	3	4	5
(9) 您容易精神紧张、焦虑不安吗？	1	2	3	4	5
(10) 您多愁善感、感情脆弱吗？	1	2	3	4	5
(11) 您容易感到害怕或受到惊吓吗？	1	2	3	4	5
(12) 您肋肋部或乳房胀痛吗？	1	2	3	4	5
(13) 您感到胸闷或腹部胀满吗？	1	2	3	4	5
(14) 您无缘无故叹气吗？	1	2	3	4	5
(15) 您感到身体沉重不轻松或不爽快吗？	1	2	3	4	5
(16) 您感到手脚心发热吗？	1	2	3	4	5
(17) 您手脚发凉吗？	1	2	3	4	5
(18) 您胃腕部、背部或腰膝部怕冷吗？	1	2	3	4	5
(19) 您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗？	1	2	3	4	5
(20) 您感觉身体、脸上发热吗？	1	2	3	4	5
(21) 您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷，夏天的冷空调、电扇等)吗？*	1	2	3	4	5
(22) 您比别人容易患感冒吗？	1	2	3	4	5
(23) 您没有感冒时也会打喷嚏吗？	1	2	3	4	5
(24) 您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗？	1	2	3	4	5

(25) 您因有季节变化、温度变化或异味等原因而咳喘的现象吗?	1	2	3	4	5
(26) 您活动量稍大就容易出虚汗吗?	1	2	3	4	5
(27) 您容易忘事(健忘)吗?*	1	2	3	4	5
(28) 您有额部油脂分泌多的现象吗?	1	2	3	4	5
(29) 您口唇的颜色比一般人红吗?	1	2	3	4	5
(30) 您容易过敏(对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时)吗?	1	2	3	4	5
(31) 您的皮肤容易起荨麻疹(风团、风疹块、风疙瘩)吗?	1	2	3	4	5
(32) 您的皮肤因过敏出现过紫癜(紫红色瘀点、瘀斑)吗?	1	2	3	4	5
(33) 您的皮肤常在不知不觉中出现青紫瘀斑(皮下出血)吗?	1	2	3	4	5
(34) 您的皮肤一抓就红, 并容易出现抓痕吗?	1	2	3	4	5
(35) 您的皮肤或口唇干吗?	1	2	3	4	5
(36) 您两颧部有细微红血丝吗?	1	2	3	4	5
(37) 您身体上有哪里疼痛吗?	1	2	3	4	5
(38) 您面部两颧潮红或偏红吗?	1	2	3	4	5
(39) 您面部或鼻部有油腻感或油亮发光吗?	1	2	3	4	5
(40) 您面色晦暗, 容易出现褐斑吗?	1	2	3	4	5
(41) 您易生痤疮或者疮疖吗?	1	2	3	4	5
(42) 您上眼睑比别人肿(上眼睑有轻微隆起的现象)吗?	1	2	3	4	5
(43) 您容易有黑眼圈吗?	1	2	3	4	5
(44) 您感到眼睛干涩吗?	1	2	3	4	5
(45) 您口唇颜色偏暗吗?	1	2	3	4	5
(46) 您感到口干咽燥, 总想喝水吗?	1	2	3	4	5
(47) 您咽喉部有异物感且吐之不出、咽之不下吗?	1	2	3	4	5
(48) 您感到口苦或嘴里有异味吗?	1	2	3	4	5
(49) 您嘴里有粘粘的感觉吗?	1	2	3	4	5
(50) 您腹部肥满松软吗?	1	2	3	4	5
(51) 您平时痰多, 特别咽喉部总感到有痰堵着吗?	1	2	3	4	5

(52) 您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉的吗?	1	2	3	4	5
(53) 您能适应外界自然和社会环境的变化吗?	1	2	3	4	5
(54) 您容易失眠吗? *	1	2	3	4	5
(55) 您受凉或吃(喝)凉的东西后, 容易腹泻(拉肚子)吗?	1	2	3	4	5
(56) 您大便粘滞不爽、有解不尽的感觉吗?	1	2	3	4	5
(57) 您容易便秘或大便干燥吗?	1	2	3	4	5
(58) 您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗?	1	2	3	4	5
(59) 您小便时尿道有发热感、尿色浓(深)吗?	1	2	3	4	5
(60) 您带下色黄(白带颜色发黄)吗?(限女性回答)	1	2	3	4	5
(61) 您的阴囊部位潮湿吗?(限男性回答)	1	2	3	4	5

附录 3

中医体质分类与判定表
平和质(A 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您精力充沛吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易疲乏吗? *	1	2	3	4	5
(3) 您说话声音低弱无力吗? *	1	2	3	4	5
(4) -19	1	2	3	4	5
(5) 您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷, 夏天的冷空调、电扇等)吗? *	1	2	3	4	5
(6) 您能适应外界自然和社会环境的变化吗?	1	2	3	4	5
(7) 您容易失眠吗? *	1	2	3	4	5
(8) 您容易忘事(健忘) 吗? *	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 基本是 ☐ 否					

注: 标有*的条目需要先逆向计分, 即: 1→5, 2→4, 3→3, 4→2, 5→1, 再用公式计算转化分。下同。

气虚质 (B 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您容易疲乏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易气短(呼吸短促, 接不上气) 吗?	1	2	3	4	5
(3) 您容易心慌吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易头晕或站起时晕眩吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您喜欢安静、懒得说话吗?	1	2	3	4	5
(7) 您说话声音低弱无力吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量稍大就容易出虚汗吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

阳虚质 (C 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您手脚发凉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您胃脘部、背部或腰膝部怕冷吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗?	1	2	3	4	5
(4) 您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷, 夏天的冷空调、电扇等) 吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉的东西吗?	1	2	3	4	5
(7) 您受凉或吃(喝)凉的东西后, 容易腹泻(拉肚子) 吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

阳虚质 (C 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您手脚发凉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您胃脘部、背部或腰膝部怕冷吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗?	1	2	3	4	5
(4) 您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷, 夏天的冷空调、电扇等) 吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉的东西吗?	1	2	3	4	5
(7) 您受凉或吃(喝)凉的东西后, 容易腹泻(拉肚子) 吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

阴虚质 (D 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到手脚心发热吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感觉身体、脸上发热吗?	1	2	3	4	5
(3) 您皮肤或口唇干吗?	1	2	3	4	5
(4) 您口唇的颜色比一般人红吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易便秘或大便干燥吗?	1	2	3	4	5
(6) 您面部两颧潮红或偏红吗?	1	2	3	4	5
(7) 您感到眼睛干涩吗?	1	2	3	4	5
(8) 您感到口干咽燥、总想喝水吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

痰湿质 (E 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到胸闷或腹部胀满吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感到身体沉重不轻松或不爽快吗?	1	2	3	4	5
(3) 您腹部肥满松软吗?	1	2	3	4	5
(4) 您有额部油脂分泌多的现象吗?	1	2	3	4	5
(5) 您上眼睑比别人肿(上眼睑有轻微隆起的现象) 吗?	1	2	3	4	5
(6) 您嘴里有黏黏的感觉吗?	1	2	3	4	5
(7) 您平时痰多, 特别是咽喉部总感到有痰堵着吗?	1	2	3	4	5
(8) 您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

湿热质 (F 型)

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您面部或鼻部有油腻感或者油亮发光吗?	1	2	3	4	5
(2) 您易生痤疮或疮疖吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到口苦或嘴里有异味吗?	1	2	3	4	5
(4) 您大便黏滞不爽、有解不尽的感觉吗?	1	2	3	4	5
(5) 您小便时尿道有发热感、尿色浓(深)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您带下色黄(白带颜色发黄)吗?(限女性回答)	1	2	3	4	5
(7) 您的阴囊部位潮湿吗?(限男性回答)	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

血瘀质 (G 型)

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您的皮肤在不知不觉中会出现青紫瘀斑(皮下出血)吗?	1	2	3	4	5
(2) 您两颧部有细微红丝吗?	1	2	3	4	5
(3) 您身体上有哪里疼痛吗?	1	2	3	4	5
(4) 您面色晦暗、或容易出现褐斑吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易有黑眼圈吗?	1	2	3	4	5
(6) 您容易忘事(健忘)吗?	1	2	3	4	5
(7) 您口唇颜色偏暗吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

气郁质 (H 型)

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到闷闷不乐、情绪低沉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易精神紧张、焦虑不安吗?	1	2	3	4	5
(3) 您多愁善感、感情脆弱吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易感到害怕或受到惊吓吗?	1	2	3	4	5
(5) 您胁肋部或乳房胀痛吗?	1	2	3	4	5
(6) 您无缘无故叹气吗?	1	2	3	4	5
(7) 您咽喉部有异物感，且吐之不出、咽之不下吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

特禀质 (I 型)

请根据近一年的体验和感觉， 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您没有感冒时也会打喷嚏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您没有感冒时也会鼻塞、鼻涕吗?	1	2	3	4	5
(3) 您有因季节变化、温度变化或异味等原因而咳嗽的现象吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易过敏 (对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时) 吗?	1	2	3	4	5
(5) 您的皮肤容易起荨麻疹 (风团、风疹块、风疙瘩) 吗?	1	2	3	4	5
(6) 您的皮肤因过敏出现过紫癜 (紫红色瘀点、瘀斑) 吗?	1	2	3	4	5
(7) 您的皮肤一抓就红, 并出现抓痕吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

附录 4

现代非连续出版物(书籍)的文献证据质量分级

证据级别	证据
一级	已发表的教材、指南、标准
二级	多次出现、可传承 (证据来源出现频次)
三级	国医大师、名医经验集
四级	其他医案医话, 个案报道, 专家经验集

附录 5

附录 5-1

JBI2014 版干预性研究证据预分级

证据等级	设计类型举例	描述
Level 1	RCT/其他实验性研究	1a 一多项 RCT 的系统评价
		1b 一多项 RCT 及其他干预性研究的系统评价
		1c 一单项随机对照实验(RCT)
		1d 一准随机对照试验
Level 2	类实验研究	2a 一多项类实验性研究的系统评价
		2b 一多项类实验性与其他低质量干预性研究的系统评价
		2c 一单项前瞻性有对照组的类实验性研究
		2d 一前后对照、回顾性对照的类实验性研究
Level 3	观察性-分析性研究	3a 一多项队列研究的系统评价
		3b 一多项队列研究与其他低质量观察性研究的系统评价
		3c 一单项有对照组的队列研究
		3d 一单项病例对照研究
		3e 一单项无对照组的观察性研究
Level 4	观察性-描述性研究	4a 一多项描述性研究的系统评价
		4b 一单项横断面研究
		4c 一病理系列研究
		4d 一个案研究
Level 5	专家意见、基础研究	5a 一对专家意见的系统评价
		5b 一专家共识
		5c 一基础研究、单项专家意见

附录 5-2

2014 版证据推荐级别

推荐级别	判定标准
A 级推荐：强推荐	1 明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
	2 高质量证据支持利用
	3 对资源分配有利或无影响
	4 考虑了患者的价值观、意愿和体验
B 级推荐：弱推荐	1 干预措施利大于弊或弊大于利,尽管证据尚不够明确
	2 有证据支持应用，尽管证据质量不够高
	3 对资源分配有利，或无影响，或有较小影响
	4 部分考虑，或并未考虑患者的价值观、意愿和体验

附录 6

附录 6-1

幽门螺杆菌感染患者体质分析及阳虚质中医护理方案构建的专家咨询问卷 (第一轮)

尊敬的专家：

您好！

感谢您抽出宝贵的时间阅读本咨询表，非常抱歉于百忙之中打扰您！我是一名在读护理研究生，目前正在进行一项“幽门螺杆菌感染患者体质分析及阳虚质中医护理方案构建”的研究。本研究旨在构建幽门螺杆菌易感体质的中医护理方案，研究此中医护理调护方案，可为胃癌一级预防工作提供借鉴和参考。前期相关调查研究中，幽门螺杆菌易感体质为：**阳虚质**，因此构建该偏颇体质的调护方案，基于文献回顾及参考相关书目，现完成该偏颇体质的调护方案构建。久仰您在此领域的学术造诣和威望，我们诚邀您作为本研究专家组成员，请您对我们的研究提出宝贵意见。

本轮专家咨询表分为两部分：第一部分为专家个人信息调查表，包含您的一般情况、熟悉程度和判断依据调查表；第二部分为专家评分咨询表，需要您逐一判断各级指标中的重要程度。请您在我们前期工作的基础上对函询内容进行评判，并填写宝贵意见和建议。您所提供的一切资料将仅作学术之用，您的个人资料与信息将会严格保密，您在问卷中涉及的观点将仅作为研究使用。

感谢您百忙之中给予的指导，本研究拟进行**两轮专家函询**，由于研究时间有限，为保证问卷的准确性及效率，请您将两部分内容填写完整，并发E-mail至_____，恳请您尽量在**14 日内**回复意见和建议。如有疑问，请拨打_____，随时与我们联系。衷心感谢您对本研究的支持与帮助！祝您身体健康，工作顺利！

右江民族医学院护理学院
研究生：覃海平
导师：时宗泽 主任护师

附录 6-2

专家基本情况调查表

填写说明：请您在空格处填写您的个人情况并在合适的选项处打钩“√”，如需进一步说明，请在空白处填写。

您的姓名：	您的年龄：	您的性别： ☐ 男 ☐ 女
您的工作单位：		您的工作年限：
您工作的部门或科室：		您的职务：
您的最高学历： ☐ 大专 ☐ 本科 ☐ 硕士 ☐ 博士 ☐ 博士后	您熟悉的领域：（可多选） ☐ 消化系统疾病 ☐ 胃肠道癌症防治 ☐ 中医“治未病” ☐ 熟悉中医体质调护 ☐ 熟悉健康教育方案构建	
您的专业技术职称： ☐ 中级职称 ☐ 副高级职称 ☐ 正高级职称	您担任该技术职称的年限： ☐ ＜3 年 ☐ 3～5 年 ☐ ＞5 年	
您是否担任导师： ☐ 硕导 ☐ 博导 ☐ 否	您担任导师的年限： ☐ ＜3 年 ☐ 3～5 年 ☐ ＞5 年	
您的联系方式	邮箱：	
	联系电话：	

附录 6-3

专家填表判断依据赋分情况表

判断依据	影响程度		
	大	中	小
(1) 理论分析	0.3	0.2	0.1
(2) 实践或科研经验	0.5	0.4	0.3
(3) 对国内外同行的了解或参考资料	0.1	0.1	0.1
(4) 直观感觉	0.1	0.1	0.1

注：工作经验的影响程度较大，分别为 0.5(大)、0.4(中)、0.3(小)；理论分析的影响程度次之，分别为 0.3(大)、0.2(中)、0.1(小)；国内外同行了解、个人直觉的影响程度相对较小，在大、中、小的程度下均为 0.1。

专家对问卷熟悉程度的赋分情况表

熟悉程度	很熟悉	熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉
专家自评	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2

幽门螺杆菌感染患者体质分析及阳虚质中医护理方案构建评价指标

专家评分咨询表（第一轮）

说明：1. 本次函询问卷包括一级指标、二级指标、三级指标，请您对各项指标的重要性依次评分，在相应处打“√”。其中在重要性评分中：1=非常不重要，2=不重要，3=中等重要，4=重要，5=非常重要。 2. 如果您认为有些指标不需要或者还可以增加或合并内容，请您在“修改意见”栏中注明，并对增加的指标进行评分。若还有其他建议，请您在列表底部填写。

阳虚质一级指标重要性评价

一级指标	专家评价					增加、减少或修改条目
	5	4	3	2	1	
A. 体质辨识						
B. 调体原则						
C. 调体要点						
D. 起居调护						
E. 精神调摄						
F. 饮食调理						
G. 运动调理						
H. 中医特色疗法						



阳虚质二级、三级指标重要性评价

二级指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
A1. 成因						A1.1 先天不足或后天失养。如孕育时父母体弱，或年长受孕，早产，或年老阳衰等。					
增加、减少或修改条目：											
二级指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1



A2. 常见 表现						A2.1 面部：面色苍白或晦暗，口唇色淡，不够红润。					
						A2.2 大便：排便不成形，容易腹泻。					
						A2.3 小便：小便清长，尿液颜色较淡，量多，次数频繁。					
						A2.4 舌质：舌头颜色淡，较胖大，边缘有齿痕。					
						A2.5 脉象：脉象沉迟无力，即脉搏跳动缓慢而无力。					
						A2.6 形体：多白胖，肌肉松软					
						A2.7 性格：多沉静、内向。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
A3. 发病 倾向						A3.1 易患感冒、关节疼痛、水肿、腹泻等。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
A4. 环境适 应能力						A4.1 耐夏不耐冬，易感风、寒、湿邪。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
B1. 因人施 治，权衡 制宜						B1.1 根据患者的个体差异，包括年龄、性别、体质、生活环境、情志状态、病情特点等诸多因素，制定出适合该患者的具体调理方法。					

增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
B2. 同病异治，异病同治						B2.1 同一种疾病，由于发病的时间、地域不同，或所处的疾病阶段或类型不同，或患者的体质不同，导致其反映出不同的证候，因而治疗方法也不一样，而不同的疾病，在其发展过程中，出现了相同的病机，因而可以采用相同的治法。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
C1. 温阳佐以养阴						C1.1 根据阴阳互根理论，在温壮元阳的同时，佐入适量补阴之品，如熟地黄、山茱萸、山药等，以达阳得阴助而生化无穷。阳虚者，用药切忌温阳太过，以免耗血伤津而转现燥热。因此，调理阳虚质时要慢温、慢补，缓缓调治。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
C2. 温阳兼顾脾胃						C2.1 调治阳虚质有益气、补火之别，除温壮元阳外，当兼顾脾胃，只有脾胃健运，始能饮食多进，化源不绝，体质强健，亦即养后天以济先天。					

增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
C3. 慎用辛 热有毒 之品						C3.1 对于附子之类的有毒温阳药及桂枝、肉桂、干姜之类的辛热温阳药，一定要在医生的指导下安全使用，切忌患者自行滥用、误用，以免出现毒副作用。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
D1. 居住 环境						D1.1 避免在阴暗、潮湿、寒冷的环境下长期工作和生活。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
D2. 生活 方式						D2.1 白天应保持一定的活动量，激发体内阳气。					
						D2.2 注意保暖，尤其是腰腹、下肢和脚部。根据天气变化及时增减衣物。					
						D2.3 睡觉前尽量不要饮水，睡前将小便排净，可每日睡前用 40~50℃的水泡脚，双脚浸泡 15 分钟左右为宜。					
						D2.4 春夏养阳，秋冬养阴可多晒太阳，但避免过度劳作，防止大汗伤阳。					

增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
D3. 作息 习惯						D3.1 保持规律的作息时间， 确保每晚 7~9 小时的睡眠 时间，尽量在晚上 10 点前 入睡，以维护身体的生物钟 和阳气循环。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
E1. 保持阳 光心态						E1.1 保持积极乐观的心态， 尽量避免和减少悲伤、惊恐 等不良情绪影响。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
E2. 加强精 神调养						E2.1 可以通过听音乐、阅 读、与朋友交流等方式舒缓 情绪。多听诸如《黄河大合 唱》等激昂、高亢、豪迈的 音乐。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
F1. 温热性 食物摄 入						F1.1 建议多摄入温热性质 的食物，如生姜、龙眼、肉 类（如羊肉、牛肉）、韭菜、 花椒等以补充阳气。					
增加、减少或修改条目：											

二级指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
F2. 易消化食物选择						F2.1 选择易消化的食物, 适量摄入高蛋白质食物, 如小米粥、南瓜粥、蛋等, 以确保营养的充分吸收和利用。					
增加、减少或修改条目:											
二级指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
F3. 避免食用生冷、寒凉、黏腻的食物						F3.1 如田螺、螃蟹、苦瓜、香蕉、甘蔗、冰淇淋、冷饮、西瓜、苦瓜、绿豆等, 即使在盛夏也不要过食寒凉之品。					
增加、减少或修改条目:											
二级指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
F4. 养成良好饮食习惯						F4.1 不饮用生水, 不生吃蔬菜。聚餐时尽量使用公筷, 家具常消毒, 饭前便后勤洗手。					
						F4.2 饮食有节, 定时定量, 不可过饥过饱。					
						F4.3 克服饮食偏嗜, 五味调配适宜, 不可偏食。					
增加、减少或修改条目:											
二级指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1

F5. 宜食药 膳举例						F5.1 当归生姜羊肉汤：温中 补血，祛寒止痛。					
						F5.2 肉桂鸡肝汤：温补肾 阳，适合阳虚质易手足发 冷、脘腹冷痛、夜尿频多者 食用。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
G1. 适当 运动						G1.1 适度的运动有助于促 进血液循环，增强体内阳 气。建议选择适合自己的运 动方式，如八段锦，每日晨 起将“两手托天理三焦”“调 理脾胃需单举”“五劳七伤 往后瞧”和“两手攀足固肾 腰”共四式练习 1~3 遍，可 调理脾胃，振奋阳气，促进 阳气的生发和疏通，每周运 动 3~5 次。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
G2. 运动 避风寒						G2.1 宜在阳光充足的环境 下锻炼，根据春夏养阳，最 好选择春夏锻炼，冬季避寒 就温，春夏多晒太阳，每次 不得少于 30 分钟。					
增加、减少或修改条目：											
二级 指标	专家评价					三级指标	专家评价				
	5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
H1. 艾灸 疗法						H1.1 常选择艾灸神阙、气 海、关元、中脘、大椎、肾 俞、命门等穴位，选择 3~6					

						个穴位，每次艾灸 20 分钟。有温补肾阳、强身健体的作用。					
增加、减少或修改条目：											
H2. 穴位 按摩						H2.1 选择脾俞、胃俞、中脘、足三里、三阴交，用拇指、食指点按每个穴位 2~3 分钟，每天 2 次。					
增加、减少或修改条目：											
H3. 穴位 贴敷						H3.1 选取含细辛、延胡索、附子、白芥子的的中药敷贴，贴于气海、关元、脾俞、足三里等穴位，贴敷至 4 小时后撕去敷贴胶布（若有不适可提前撕去），抹去残留药膏即可，每天 1 次。					
增加、减少或修改条目：											
H4. 雷火灸 疗法						H4.1 可选取神阙、中脘、关元、气海、大椎、百会等，选择 3~6 个穴位，每次艾灸 20 分钟，每天 1 次。					
增加、减少或修改条目：											

综述

中医特色护理在幽门螺杆菌感染防治中的创新应用与进展

摘要：幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*, Hp）感染是全球性的公共卫生问题，与多种胃部疾病密切相关。中医特色护理在幽门螺杆菌感染的防治方面展现出独特的优势和潜力，本文旨在综述中医特色护理在 Hp 感染防治中的创新应用与进展。通过分析中医理论与现代医学研究的结合，总结研究成果，为中医特色护理在该领域的进一步发展提供参考，并对未来研究方向提出展望，旨在推动中医特色护理在 Hp 感染防治中的广泛应用和创新发展。

关键词：中医特色护理；幽门螺杆菌；感染防治；创新应用；进展

Innovative application and progress of traditional Chinese medicine characteristic nursing in prevention and treatment of *Helicobacter pylori* infection

Abstract : *Helicobacter pylori* infection is a global public health problem and is closely associated with a variety of stomach diseases. TCM characteristic nursing has shown unique advantages and potential in the prevention and treatment of *Helicobacter pylori* infection. This article aims to review the innovative application and progress of TCM characteristic nursing in the prevention and treatment of Hp infection. By analyzing the combination of TCM theory and modern medical research, this paper summarizes the research results, provides references for the further development of TCM characteristic nursing in this field, and puts forward prospects for future research directions, aiming at promoting the extensive application and innovative development of TCM characteristic nursing in the prevention and treatment of Hp infection.

Key words: TCM characteristic nursing; Helicobacter pylori; Infection prevention and control; Innovative application; progress

幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*, Hp）是一种定植于人体胃部的螺旋形革兰氏阴性菌，可通过口-口、粪-口及胃-口等多种途径传播，因此在人群中普遍易感，具有高感染率^[1]。据 2012 年~2022 年中国流行病学的 Meta 分析数据表明，我国的 Hp 综合感染率为 42.11%^[2]，而家族性 Hp 感染率较高，总体家庭感染率为 71.2%，个体感染率为 40.7%^[3]。Hp 感染是导致胃炎、消化性溃疡、胃癌等消化系统疾病的相关因素^[4]，作为危害人类健康的典型病菌之一，Hp 早在 1991 年就被世界卫生组织列为胃癌的 I 类致癌原^[5]。感染 Hp 后会使得免疫功能紊乱，会出现腹痛、反酸、食欲不振、消化不良、口臭等症状，严重降低患者生活质量。目前，我国 Hp 感染和胃癌仍双重高发，且二者关系密切，危害相互叠加，因此极早杀灭 Hp 对预防和控制胃部疾病有重要促进作用^[6-7]。

近年来，中医药治疗因副作用少、效果好而逐渐被应用，中医特色护理也应用于此类患者的临床治疗中，对改善患者临床症状具有十分积极的意义。目前已有不少关于中医特色护理在 Hp 感染治疗中的原始研究，但缺乏相关综述，因此本研究通过综述中医特色护理在 Hp 感染防治中的创新应用与进展，总结研究成果，为中医特色护理在该领域的进一步发展提供参考，并对未来研究方向提出展望，旨在推动中医特色护理在 Hp 感染防治中的广泛应用和创新发展。

1 中医特色护理防治 Hp 的理论依据

1.1 中医对 Hp 感染的认识

虽然中医经典中没有“Hp”一词，但从临床症状来看，与 Hp 感染相关的胃病属于中医的“胃痛”嘈杂“痞满”和“泛酸”范畴^[8]。多项研究提到 Hp 感染与湿热关系密切，认为导致 Hp 感染的外因是外邪，内因是脾胃的正气亏损^[9-11]，然而也有医学世家将 Hp 称之为中医“虫”范畴中的无形之虫，认为是脾胃外感，湿热生虫所致^[12]。目前现代多数医家将其归属于“邪气入侵”，“邪气”经口而入，直中脏腑，引发疾病^[13-14]。

外邪入侵，如现代人饮食习惯偏于油腻、辛辣、生冷，易损伤脾胃，导致湿热内生，为Hp提供生长土壤。脾胃不足也是重要原因，脾为后天之本，主运化水谷精微，当脾胃功能受损时，水谷精微运化失常，湿热内生。同时，长期饮食不规律、暴饮暴食等不良饮食习惯会加重脾胃负担，使湿热之邪更易滋生。

1.2 中医特色护理方法的理论依据

中医特色护理以整体观念和辨证施护为特色，通过独特的中医护理技术发挥作用，常用的中医护理技术有灸法、穴位按摩法、拔罐、刮痧、耳穴贴压及耳穴压豆等^[15]。

2 中医特色护理方法在 Hp 感染中的应用

2.1 穴位贴敷的应用及效果

穴位贴敷是指将药物贴于特定穴位，刺激经络，调节脏腑功能。穴位贴敷疗法可以避免口服给药和个体耐受性所引起的肝脏和肾脏功能损伤，具有不良反应少、安全性强、经济实用、操作简便、疗效确切等特点。刘萍等^[16]选取丁香、茯苓、莲子、炒山楂、山药等药物磨成药末，用新鲜姜汁配置成药糊应用于Hp感染患者，贴敷于中脘穴、关元穴、气海穴、足三里穴等处，可起到行气和胃健脾、杀菌消食等作用；时燕^[17]选择用穴位贴敷太冲穴、气海、关元、阴陵泉等穴位，治疗后患者抗病能力得以增强，炎症减轻，进而改善患者生活质量，与何锦雄等^[18]研究一致。穴位贴敷治疗可根据患者Hp感染相关胃炎等不同病情选择相应的药材进行调制，给予个性化治疗，临床常用的药物调制方法为干姜 15g、白芥子 5g、细辛 5g、吴茱萸 15g，将其研成粉末，加入姜汁调配成膏状。常选择贴敷穴位为：中脘、足三里、神阙、气海、关元、太冲、阴陵泉等穴位，每日 1 次，每次贴敷 2~4 小时，贴敷时间需要根据药物的性质和患者的皮肤耐受程度而定^[16-21]。穴位敷贴应用与胃肠道相应穴位能够起到强健脏器功能的效用，同时还具有调节阴阳，强化胃肠道功能之效，对Hp感染防治有一定的治疗效果。

2.2 耳穴贴压的应用及效果

耳穴贴压能调节气血、阴阳平衡。中医认为，耳朵与五脏六腑和经络有着密切的联系，人的五脏六腑和全身各个部位都可以在耳朵找到相应的位置，用王不留行籽耳穴贴贴于相应穴位，通过刺激局部耳穴，调节气血，达到治疗疾病的目的，它主要遵循耳针、

中医辨证的原则,选择一定的穴位进行组合,以调整相应脏腑经络气血的功能^[15]。例如,对于 Hp 感染的患者,时燕^[17]选择耳穴贴压耳廓穴位,贴压交感穴、神门、皮质下及胃、脾耳穴,与耳穴贴压联合一起,均增强了病人的抗病能力,减少胃肠道反应,提高生活质量;李白玉等^[22]取耳穴:心、脾、胃、肝、神门、皮质下对有典型胃部不适症状,如胃痛、食欲不振、烧心、反酸、恶心、呕吐等临床症状的 Hp 感染者进行耳穴贴压治疗,治疗后患者 Hp 根除率上升,临床症状评分降低,说明治疗有效,与周宁^[23]研究一致。耳穴贴压部位可选择皮质下、脾、胃、交感、神门等穴,根据患者存在的不同临床症状可增加取穴,护士对耳部穴位进行消毒,将王不留行籽贴敷于耳部穴位,并叮嘱患者每日进行按压 1 次,直到出现痛、胀或麻的感觉,两耳交替按压,14 天为 1 个疗程,注意观察贴压后耳部皮肤情况,若出现红肿、瘙痒等过敏现象,应及时取下贴压物,并用抗过敏药物处理^[19-23]。耳穴贴压能够达成疏肝理气、驱散郁滞之效,助力调和人体阴阳,促使经络畅达、气血流通无碍,实现对脏腑机能的良性调节与疏通,应用于 Hp 感染患者,可使患者身体的不适感逐渐减轻,提高了生活质量。

2.3 穴位按摩的应用及效果

穴位按摩是利用特殊的手法作用于人体体表的特定部位或穴位,以达到疏通经络、祛寒止痛、健脾和胃、消积化滞、扶正祛邪,从而达到养生保健、促进疾病治疗目的的一种治疗方法^[15]。梅晓杰等^[24]在一项穴位按摩在 Hp 感染慢性胃炎中的应用效果研究中,将患者分为中医穴位按摩组和常规护理组,经过一段时间的护理后,穴位按摩组的疼痛减轻、疼痛持续时间缩短、复发控制率提高,患者的生活质量得到改善,改善程度明显优于常规治疗组;张子曼等^[25]在针对 Hp 感染给予个性化穴位按摩护理,气虚者可多按摩气海、俞穴等穴位,阴虚者可按摩足三里、三阴交等穴,通过穴位按摩舒缓经络,增强病人的胃肠功能以及抗病能力,促进了病人的康复,患者依从度、满意度高,与丁嘉妮等^[26]研究一致。按摩选穴常以中脘、脾俞、胃俞、足三里、内关、神阙等穴为主,以指腹进行按摩,每穴按摩 2~5 分钟,每天按摩 1~2 次,持续 2 个月,按摩力度要适中、均匀、持久、柔和,由轻到重,再由重到轻,根据患者的体质、病情和耐受程度调整力

度^[24-27]。穴位按摩在防治 Hp 感染方面主要为活血通络、提升机体免疫力，能够直接或间接地影响脏腑的生理功能，具有操作简单、安全有效、无药物不良反应等优点。

2.4 灸法的应用及效果

灸法是指用一定的燃烧物熏灼或温熨于人体某些部位的表面，通过灸火的热力和药物的作用，通过对经络和穴位的刺激，达到温通经络、活血行气、散寒除湿、消肿散结、回阳固本的作用，达到逆转和预防保健的效果^[15]。《医学入门》说：“凡病，药之不及，针之不刺，必须灸之。”艾灸的材料很多，但以艾叶制成的艾绒最为重要，因其味苦、辛，性温无毒，主灸百病，尤其适用于慢性衰弱性疾病，以及风寒湿痹为患之症，如中热寒呕、腹痛泄泻、脾肾阳虚等。马刚等^[28]在脾胃虚寒型 Hp 阳性慢性萎缩性胃炎患者治疗中用黄芪建中汤联合灸法配穴中脘穴、足三里穴治疗，可提高临床疗效与 Hp 根除率，与传统治疗措施相比，它能更好地改善临床症状，减轻炎症程度，且无明显副作用，治疗更安全，值得临床应用；林慧玲^[29]通过对脾胃虚寒证 Hp 相关消化性溃疡进行大椎、足三里、胃俞、脾俞、中脘等穴施灸，结果显示电子灸的联合应用有效改善胃脘疼痛、胸胁胀满、纳差等症状，降低消化性溃疡的中医证候积分，提高中医证候疗效，减少西药治疗消化性溃疡带来的不良反应率，与王明华^[30]研究一致。灸法可通过提高温度、扩张血管使其促使胃粘膜的自我调节损伤修复，对 Hp 感染防治发挥积极作用，也证明了灸法与脏腑经络的理论系统有关^[31]。所灸穴位一般选择胃俞、脾俞、中脘、足三里等穴，以局部温热感为宜，每天 1 次，每次灸 20 分钟，灸法时掌握好施灸的距离和温度，防止烫伤，注意保护患者隐私，注意保暖，避免着凉^[28-30]。

2.5 中医特色护理技术在 Hp 感染防治应用中的总体评价

中医特色护理认为人体是一个有机的整体，疾病的发生和发展与人的整体功能失调有关。因此，在护理过程中，中医特色护理和现代护理都注重从整体上评估患者的健康状况，制定个性化的护理计划，综合运用各种护理手段，促进患者的整体康复。在 Hp 感染防治中涵盖了穴位贴敷、耳穴贴压、穴位按摩及灸法等多种经典中医特色护理技术，其疗法多样且彰显其操作简便、安全、副作用少、耗材成本低等优势，例如耳穴贴压及穴位按摩操作简单，居家可行，经济负担少，方便患者持续保健、巩固疗效，提

升就医获得感及满意度。这些中医特色护理技术在研究中可改善 Hp 感染患者胃部不适、减轻疼痛，提高 Hp 根除率，对 Hp 感染防治有着积极的作用，可在未来研究中进行进一步推广。

3 中医特色护理中的膳食疗法与情志护理

3.1 膳食疗法的个性化应用及成效

中医强调“饮食养生”，认为适当的饮食调理有助于维持人体的平衡。饮食起居被认为是导致 Hp 感染的主要因素^[32]，在防治 Hp 感染中，中医建议避免辛辣、油腻食物，多食用清淡、容易消化的食物，以减轻胃黏膜的刺激，促进胃肠功能的正常运行。合理的饮食结构可以影响胃黏膜的微环境，阻止 Hp 的生长，例如脾胃虚寒者长期适量食用山药、薏苡仁等，能起到温补驱寒、养血止血之效用，此外还能增强脾脏功能；气血不足患者食用鱼肉、猪肝有助于增强肝脏功能，同时也能起到补血的效用，如红枣、桂圆则是补血佳品；肝郁气滞者食用玫瑰花、陈皮等中药材有助于养肝行气，增强机体抗病能力；脾胃湿热型者食用藕粉、绿豆汤等，能达到清热燥湿，凉血止血之效^[20]。相关研究表明，Hp 可以在牛奶、新鲜水果和蔬菜、新鲜肉类中存活^[33]，因此在中医基础上推荐结合西医饮食治疗方案，如交代病人养成良好的饮食习惯，尽量少吃或不生食蔬菜，在日常生活中还应避免油腻、辛辣、刺激性食物，如腌制食品、油炸食品等，可适当食用豆类食品、蜂胶及蒜等食物^[34]。也有研究表明，进食高盐辛辣腌制食品以及高脂肪、高糖食物，会在很大程度上增加 Hp 感染风险，但适量食用生蒜及豆制品，则能够降低这类病原体的感染^[35-39]。

关于 Hp 感染饮食调护，以中西医结合的护理方式更值得应推广。Hp 感染管理规范中提出，我们应该养成良好的卫生习惯，做到饭前便后洗手、注意口腔卫生、生活用水卫生等；提倡聚会就餐时使用“公筷、公勺”并推行“分餐制”，减少口-口传播 Hp 的几率^[1]。而中医膳食疗法中针对 Hp 感染不同证型给与相应的饮食调护，体现了中医特色护理的辨证施护与现代护理的个性化护理理念相呼应，我们应该充分利用中西结合的护理方式进行 Hp 感染防治，提高全民健康。

3.2 情志护理的应用及积极影响

根据中医学相关理论,人有喜、怒、忧、思、悲等七情,其主要是在各种内外因素刺激作用下,人体表现出的各种情志反应。对健康者而言,七情在一定范围内不会致病,但超出范围后可能由于强烈的反应而导致脏腑气血功能紊乱,进而出现相关疾病,情志护理就是在七情相关的中医学理论指导下,做好沟通工作的同时应用科学的护理方法对患者进行护理,以此来改善其负面情绪,防治病变的一种护理方法^[15]。近年来,已有研究表明,焦虑及抑郁会增加 Hp 感染风险^[40],且 Hp 感染患者常伴有不良心理状态并且常容易受外界环境及心理因素的影响^[41-42]。而良好的心理状态以及健康生活方式等是防治 Hp 的方法之一^[7],因此在中医情志调理中,对于 Hp 感染患者,主要为引导患者保持情绪舒畅,日常生活中尽量减少生气,自我调节内心状况,让患者意识到保持健康积极心态的重要性,避免产生焦虑、恐慌,鼓励保持平和、开朗的心态,树立战胜疾病的信心和勇气^[17]。

五行音乐疗法是在中医学理论基础上形成的一种中医情志治疗方法,五音属五行,应五脏,动五志,与脏腑的生理特性相互照应^[43]。基于这种方法,在治疗时将五音(角、徵、宫、商、羽)与五脏(心、肝、脾、肺、肾)相对应,根据患者的病变所属,通过对应的音乐进行干预,从而改善身心状况^[44]。薛静等^[45]对癌症化疗病人在干预过程中选择了音乐疗法,对比发现干预后此类患者常见的副反应如恶心、呕吐明显缓解,生活质量和化疗依从性则大幅度提高;张华健等^[46]在探讨五行音乐宫调在胃癌病人的应用效果中得出宫调有利于改善胃癌病人生活质量及预后的结论。现代医学研究发现五行音乐疗法的原理是五脏都有各自的振动频率,而这些频率和五行音乐存在一定对应关系,五行音乐释放的能量对体内气血有一定调节作用,从而实现特定治疗的目的^[47]。五行音乐疗法需要注意体质、年龄、疾病状态的差异,结合患者情绪状态,精准对应,例如,阳虚体质的人,身体阳气不足,可能对属火的徵音更为敏感,在聆听时要注意控制时间和音量,因为徵音有振奋阳气的作用,过度聆听可能会导致阳气过亢,出现口干舌燥、心烦等上火的症状。

中医上讲的情志疗法与西医的心理疗法不谋而合,在患者心理承受着悲伤、焦虑、失眠、抑郁等症状时及时给予心理疏导及有效沟通,对患者不良情绪进行排解,引导健

康的生活行为方式。而五行音乐疗法是中医独特的情志疗法之一，认为五音与五脏有着密切的联系，如心主神明，徵音可以养心安神。对于有沮丧、悲伤、睡眠质量差等症状的 Hp 感染患者可根据具体症状选择相应的五行音乐疗法来调畅情志、调节脏腑机能，改善睡眠质量以辅助疾病治疗。

4 小结

中医特色护理在 Hp 感染防治中取得了积极的成果。相应的中医护理技术有穴位贴敷、耳穴贴压、穴位按摩、灸法等，能够调节气血、阴阳平衡，调畅气机、改善微循环，为 Hp 感染的治疗创造有利条件；在临床症状改善方面，这些中医特色护理项目能有效缓解腹胀、胃脘痛、反酸或嗝气等症状，提高 Hp 根除率及患者的生活质量；中医膳食疗法及五行音乐疗法也是 Hp 感染患者进行身体机能调节、改善心理状态、促进身体康复的重要中医护理方法。未来在防治 Hp 感染领域，可以开展大规模中医特色护理临床研究，验证中医特色护理在不同人群、不同病情阶段的有效性和安全性，还可以结合现代科技手段，如大数据分析、人工智能等，为中医特色护理提供更加科学的依据和个性化的方案。

参考文献

- [1] 胡奕, 祝荫. 幽门螺杆菌感染治疗的规范化管理[J]. 中国实用内科杂志, 2023,43(4): 292-295.
- [2] 朱红梅, 刘颖初, 薛元, 等. 2012 — 2022 年中国幽门螺杆菌流行病学 Meta 分析[J]. 预防医学情报杂志, 2023,39(9):1124-1137.
- [3] ZHOU X, LYU N, ZHU H, et al. Large-scale, national, family-based epidemiological study on *Helicobacter pylori* infection in China: the time to change practice for related disease prevention[J]. Gut, 2023,72(5):855-869.
- [4] 林垵皓. 幽门螺杆菌根除治疗失败的危险因素分析及风险预测模型的构建[D]. 南方医科大学, 2023.
- [5] CANCER I A F R. Schistosomes, liver flukes and *Helicobacter pylori*. [Z]. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum: 1994: 61, 1-241.
- [6] 李贤莉, 易平, 严群, 等. 中医辨证施护对幽门螺杆菌感染消化性溃疡患者的干预效果分析[J]. 时珍国医国药, 2022,33(09):2192-2194.
- [7] 易惺钱. 基于扶正祛邪理论的中医药治疗幽门螺杆菌感染相关疾病的证治规律研究 [D]. 江西中医药大学, 2021.
- [8] 吴佳栩. 幽门螺杆菌感染患者症状特征与中医体质相关性研究[D]. 北京中医药大学, 2021.
- [9] 李京尧, 王盼, 刘文静, 等. 幽门螺杆菌相关性胃炎患者中医体质与中医证型相关性研究[J]. 时珍国医国药, 2020,31(10):2416-2418.
- [10] 胡伏莲, 张声生. 全国中西医整合治疗幽门螺杆菌相关“病—证”共识[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2018,26(9):715-723.
- [11] 张弘, 何凌. 幽门螺旋杆菌感染中医病因探讨[J]. 辽宁中医药大学学报, 2018,20(1): 190-192.

- [12] 刘斌斌, 胡运莲, 林敏, 等. 幽门螺杆菌感染与中医“湿热生虫”关系的研究[J]. 中国中医基础医学杂志, 2019,25(08):1094-1096.
- [13] 陈署洪, 吕冠华. 中西医治疗幽门螺杆菌感染研究进展[J]. 中外医学研究, 2023,21(5):175-180.
- [14] 游佳琪. 幽门螺杆菌感染的中医体质分布及相关危险因素分析[D]. 黑龙江中医药大学, 2022.
- [15] 孙秋华. 《中医护理学》[M].第5版.北京: 人民卫生出版社, 2022.
- [16] 刘萍, 瞿凡, 徐阳, 等. 中药穴位贴敷联合三联疗法治疗幽门螺杆菌感染疗效观察[J]. 山西中医, 2023,39(05):48-49.
- [17] 时燕. 中医干预对 H. pylori 感染致胃痛患者的疗效[J]. 河北医药, 2022,44(15):2340-2346.
- [18] 何锦雄, 张凤敏. 中药穴位贴敷疗法治疗脾胃虚寒型慢性胃炎的临床观察[J]. 实用中西医结合临床, 2022,22(19):18-21.
- [19] 陈艳美, 王梅. 中医护理对幽门螺杆菌相关性胃炎患者的干预效果[J]. 世界最新医学信息文摘, 2020,20(100):304-305.
- [20] 王畅, 鲁丹, 唐雪梅. 中医护理对幽门螺杆菌相关性胃炎患者的干预效果[J]. 当代护士(中旬刊), 2019,26(2):98-100.
- [21] 邓娟娟, 邓琼琪, 罗尧岳. 穴位敷贴联合三联疗法对脾胃虚弱型 Hp 相关性胃病的护理效果观察[J]. 湖南中医杂志, 2021,37(6):94-96, 177.
- [22] 李白玉, 周炜. 针刺联合耳穴贴压治疗幽门螺杆菌感染胃炎 30 例[J]. 中国针灸, 2021,41(9):991-992.
- [23] 周宁. 耳穴贴压对十二指肠球部溃疡患者胃泌素、幽门螺杆菌及生活质量的影响[D]. 福建中医药大学, 2012.
- [24] 梅晓杰, 钟阳. 穴位按摩在幽门螺杆菌感染慢性胃炎中的应用效果[J]. 光明中医, 2020,35(11):1690-1692.
- [25] 张子曼, 李睿钧, 张曼兰, 等. 基于循证理论的中西医结合路径化干预对牙周炎幽

- 门螺杆菌感染病人的影响[J]. 全科护理, 2020,18(35):4935-4937.
- [26] 丁嘉妮, 胡峰, 郁培, 等. 中医特色护理对幽门螺杆菌相关性胃炎的护理效果[J]. 中外医疗, 2023,42(35):143-146.
- [27] 卜海珠, 胡华娟, 腾惠兰, 等. 穴位按摩对幽门螺杆菌感染慢性胃炎的护理疗效观察[J]. 现代诊断与治疗, 2016,27(23):4582-4584.
- [28] 马刚, 张西青, 马璨, 等. 黄芪建中汤联合合募配穴灸法辅助治疗脾胃虚寒型幽门螺杆菌阳性慢性萎缩性胃炎的疗效观察[J]. 中华养生保健, 2024,42(15):16-19.
- [29] 林慧玲. 电子灸联合四联疗法治疗 Hp 相关消化性溃疡(脾胃虚寒证)的临床研究[D]. 福建中医药大学, 2020.
- [30] 王明华. 隔附子饼灸结合西药治疗虚寒型消化性溃疡的临床研究[D]. 广州中医药大学, 2018.
- [31] 蒋志惠, 常雪梅, 张照然, 等. 艾草的化学成分和药理作用研究进展[J]. 中国兽药杂志, 2019,53(02):76-85.
- [32] 张万岱, 胡伏莲, 萧树东, 等. 中国自然人群幽门螺杆菌感染的流行病学调查[J]. 现代消化及介入诊疗, 2010,15(05):265-270.
- [33] Zamani M, Vahedi A, Maghdouri Z, et al. Role of food in environmental transmission of *Helicobacter pylori*[J]. Caspian journal of internal medicine, 2017,8(3):146-152.
- [34] 林华琴, 黄美娜, 李碧真. 自我行为与饮食护理干预对幽门螺杆菌感染患者自我效能与预后的影响[J]. 吉林医学, 2023,44(7):2003-2005.
- [35] 徐丽琴, 杨齐华, 顾君娣, 等. 学龄前儿童幽门螺杆菌感染状况及其影响因素调查分析[J]. 中国妇幼保健, 2020,35(7):1316-1318.DOI:10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2020.07.046.
- [36] 张明伟, 汪建超, 王启之, 等. 安徽中南部地区幽门螺杆菌流行病学调查[J]. 中华全科医学, 2020,18(8):1395-1398.
- [37] Shu L, Zheng P, Zhang X, et al. Dietary patterns and *Helicobacter pylori* infection in a group of Chinese adults ages between 45 and 59 years old[J]. Medicine,

2019,98(2):e14113.

- [38] 王文玲, 宋晓梅, 赵玲. 幽门螺杆菌感染的危险因素及相关护理干预对策研究[J]. 国际医药卫生导报, 2020,26(8):1161-1164.
- [39] 吴寒寒, 王陈, 汪光军, 等. 安徽省某胃癌高发县 40~69 岁居民食盐及腌渍食物摄入与幽门螺杆菌感染状况的调查与分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2020,24(02):164-169.
- [40] 鲁钰, 方向明. 有消化道症状者幽门螺杆菌感染与焦虑抑郁状态的相关性[J]. 武警后勤学院学报(医学版), 2021,30(4):22-26.
- [41] Alhalabi M, Alassi M W, Alaa E K, et al. Efficacy of two-week therapy with doxycycline-based quadruple regimen versus levofloxacin concomitant regimen for helicobacter pylori infection: a prospective single-center randomized controlled trial[J]. BMC Infect Dis, 2021,21(1):642.
- [42] 徐婷婷. 临床护理路径对消化性溃疡患者幽门螺杆菌根除率、心理情绪及遵医行为的影响[J]. 河南医学研究, 2020,29(31):5936-5938.
- [43] 高昭, 曾静, 吕品, 等. 中医五音疗法干预气虚质人群临床观察[J]. 河北中医, 2024, 46(7):1065-1069, 1073.
- [44] 吕俭霞, 高静, 苟朝琴, 等. 五行音乐疗法改善肿瘤病人生存质量及负性情绪研究的方法学及报告质量评价[J]. 循证护理, 2018,4(2):117-123.
- [45] 薛静, 张丽燕, 杨琪. 音乐治疗缓解癌症患者化疗后恶心呕吐改善生活质量的研究[J]. 护理学报, 2017,24(01):70-72.
- [46] 张华建, 肖红, 吁佳, 等. 五行音乐宫调配合穴位按摩在胃癌晚期病人安宁疗护中的应用[J]. 护理研究, 2020,34(24):4379-4383.
- [47] 张荣荣, 顾丽雅, 庄建红. 中医五行音乐结合语言诱导对维持性血液透析患者生活质量和精神状况的影响[J]. 新中医, 2019,51(11):267-270.